Perfil V3 · código por código

Endocrinología

Los 42 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Endocrinología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 23 códigos

1.03.1.001 Bocio

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.9 Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

QUÉ HAY QUE SABER

- Bocio: aumento de volumen tiroideo difuso o nodular; puede ser eutiroideo, hipotiroideo (Hashimoto, bocio firme) o hipertiroideo (Graves difuso con soplo, bocio multinodular tóxico).
- Primer examen: TSH (y T4 libre si está alterada), porque define la conducta; luego ecografía tiroidea para morfología y nódulos.
- PAAF solo en nódulos con criterios ecográficos (TI-RADS y tamaño); cintigrama solo si la TSH está suprimida.
- Inicial: corregir la función (levotiroxina si hay hipotiroidismo; tiamazol y propranolol si hay hipertiroidismo). La levotiroxina supresora para reducir bocio o nódulos está en desuso.
- Derivar a endocrinología o cirugía si hay síntomas compresivos (disfagia, disfonía, estridor), bocio grande (>80 g), crecimiento rápido, nódulo sospechoso o hipertiroidismo para terapia definitiva.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Una mujer de 35 años consulta por aumento de volumen cervical anterior difuso, indoloro y de crecimiento lento. No tiene síntomas de hipo ni de hipertiroidismo, ni síntomas compresivos. Al examen la tiroides está aumentada de tamaño en forma simétrica, blanda, sin nódulos palpables. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado?**
> **A)** TSH
> **B)** Punción aspirativa con aguja fina (PAAF) de tiroides
> **C)** Cintigrama tiroideo
> **D)** TAC de cuello
> **E)** Tiroglobulina
> Respuesta A. Ante todo bocio, lo primero es evaluar la función tiroidea con TSH (y T4 libre si está alterada), porque define la conducta. La ecografía tiroidea complementa la evaluación morfológica y de nódulos. La PAAF solo se indica en nódulos según criterios ecográficos, y el cintigrama en hipertiroidismo con TSH suprimida.

1.03.1.002 Hipotiroidismo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina · Tema 1.3 Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas · Tema 1.4 Hipotiroidismo en Situaciones Especiales: Embarazo y Tamizaje Neonatal Congénito · Tema 1.5 Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa principal en Chile: tiroiditis de Hashimoto (anti-TPO y anti-Tg positivos); otras: radioyodo, tiroidectomía, amiodarona, litio. Clínica: astenia, intolerancia al frío, constipación, aumento de peso moderado, piel seca, bradicardia, relajación lenta del aquiliano.
- Diagnóstico: TSH alta con T4 libre baja (clínico) o normal (subclínico). Puede dar dislipidemia, anemia, hiponatremia y CK elevada, que se corrigen con levotiroxina (no partir con estatinas).
- Subclínico: tratar siempre si TSH ≥10; con TSH 4,5–9,9 tratar si hay embarazo o deseo de embarazo, anti-TPO positivos, bocio, síntomas o enfermedad cardiovascular; mayores de 70–80 años asintomáticos con TSH <10, observar.
- Levotiroxina (GES): 1,6 mcg/kg/día de peso ideal en el joven sano; adulto mayor o coronario 25–50 mcg/día (12,5 si coronariopatía grave) subiendo 12,5–25 mcg cada 6–8 semanas. Tomar en ayunas con agua, 30–60 min antes del desayuno, separada 4 h de hierro, calcio, antiácidos e IBP.
- Seguimiento: TSH a las 6–8 semanas de cada cambio, meta 0,5–2,5 mUI/L; antes de subir la dosis, revisar cómo la toma. Embarazo: subir la dosis 20–30 % al confirmarlo. Hipotiroidismo central: controlar con T4 libre y descartar insuficiencia suprarrenal antes de iniciar.

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 15

Una paciente de 27 años, en amenorrea por lactancia, presenta un cuadro de astenia y malestar general, constipación y dificultades para concentrarse, asociado a intolerancia al frío. Además, refiere que no ha podido bajar de peso. Al examen físico tiene FC: 67x', PA: 120/80 mmHg, se aprecia piel seca y cabello ralo, sin otras alteraciones en el examen físico segmentario. Se solicitan exámenes de laboratorio que muestran TSH: 14,7 UI/L, T4 libre: 0,6 ng/dl, T3: 46 ng/dl. **¿Cuál es la conducta más adecuada en este momento?**

A) Iniciar tratamiento con levotiroxina oral
B) Solicitar ecografía tiroidea
C) Solicitar cintigrafía tiroidea
D) Solicitar prueba de captación de yodo radiactivo
E) Repetir los exámenes en 6 semanas

Respuesta A. Hipotiroidismo clínico: síntomas y T4 libre baja con TSH alta. Se inicia levotiroxina. Aun si fuera subclínico, una TSH sobre 10 obliga a tratar. Las imágenes no cambian la conducta.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 21

Una paciente de 17 años, con hábitos de vida sedentarios y obesidad se realiza exámenes de control, en los que presenta TSH: 6,5 UI/L, T4 libre: 1,5 ng/dl (VN: 0,7 a 1,9 ng/dl) y T3 libre 300 pg/dl (VN: 130 a 450 pg/dl). **La conducta más adecuada es:**

A) Iniciar levotiroxina
B) Controlar hormonas tiroideas en 6 meses
C) Solicitar anticuerpos antiperoxidasa tiroidea
D) Solicitar ecografía tiroidea
E) Solicitar cintigrafía tiroidea con yodo radiactivo

Respuesta B. Hipotiroidismo subclínico (TSH 6,5 con T4 libre normal) sin factores agravantes: no requiere tratamiento y se controla. La obesidad no es un criterio para iniciar levotiroxina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 110

Una paciente de 35 años presenta un cuadro de astenia importante. Al examen físico tiene FC: 59x', PA: 110/70 mmHg, se aprecia palidez, ictericia, vitiligo, edema de EEII, piel seca, con pelo quebradizo. En sus exámenes tiene hematocrito: 27%, con VCM: 110. **El diagnóstico más probable es:**

A) Depresión
B) Daño hepático crónico
C) Déficit de vitamina B12
D) Enfermedad de Addison
E) Hipotiroidismo

Respuesta E. Bradicardia, piel seca, pelo quebradizo y edema: hipotiroidismo. La anemia macrocítica y el vitíligo apuntan a autoinmunidad asociada (anemia perniciosa), pero el cuadro global lo explica el hipotiroidismo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 36

Un paciente se realiza una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspende el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. **¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examen físico?**

A) Mixedema pretibial
B) Exoftalmo
C) Melanoplaquias
D) Piel seca
E) Acantosis nigricans

Respuesta D. Sin tiroides y sin levotiroxina, el paciente está hipotiroideo: piel seca. El mixedema pretibial y el exoftalmo son de la enfermedad de Graves; las melanoplaquias, del Addison; y la acantosis nigricans, de la resistencia a la insulina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 119

¿Cuál es la conducta más adecuada ante una paciente embarazada en el primer trimestre, que presenta una TSH de 4,5 UI/L? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar propiltiouracilo
B) Solicitar T4 libre
C) Iniciar levotiroxina
D) Solicitar una nueva TSH en un mes
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta C. La meta de TSH en el primer trimestre es < 2,5. Con 4,5, sea hipotiroidismo clínico o subclínico gestacional, la conducta es tratar con levotiroxina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 173

Una paciente de 27 años consulta por un cuadro clínico de un año de evolución caracterizado por astenia, adinamia y malestar general. Además, ha aumentado 8 kg de peso y en el último mes presenta sensación de frío, constipación y mialgias. Al examen físico presenta lentitud en el lenguaje verbal y el razonamiento, piel seca y fría con vitíligo en la cara y manos, y alopecia moderada en el cuero cabelludo. Su frecuencia cardíaca es de 60 latidos por minuto y su presión arterial de 130/80 mmHg. Se constata edema bilateral de extremidades inferiores, sin fóvea. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?**

A) Hemograma - VHS
B) Colonoscopía
C) Niveles de cortisol
D) TAC de cerebro
E) TSH

Respuesta E. Aumento de peso, frío, constipación, bradipsiquia, piel seca, bradicardia y edema sin fóvea (mixedema), con vitíligo como marcador de autoinmunidad: hipotiroidismo, probablemente por tiroiditis de Hashimoto. El examen de elección para iniciar el estudio es la TSH, idealmente junto a la T4 libre.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 36

Un paciente se realizó una tiroidectomía total hace varios años, por un carcinoma tiroideo. Suspendió el tratamiento con levotiroxina hace 6 meses. **¿Qué alteración tendrá con mayor probabilidad en su examen físico?**

A) Mixedema pretibial
B) Exoftalmo
C) Melanoplaquias
D) Piel seca
E) Acantosis nigricans

Respuesta D. Sin tiroides y sin levotiroxina desarrolla un hipotiroidismo, cuyo signo cutáneo típico es la piel seca, fría y áspera. El mixedema pretibial y el exoftalmo son propios de la enfermedad de Graves, las melanoplaquias de la enfermedad de Addison y la acantosis nigricans de la resistencia a la insulina.

Pregunta de práctica

Mujer de 62 años, hipertensa controlada, con 6 meses de astenia, constipación y aumento de 4 kg. FC 54 lpm, piel seca y fría, relajación aquiliana prolongada y tiroides difusamente aumentada, firme e indolora. TSH 42,5 mUI/L, T4 libre 0,41 ng/dL, colesterol total 268 mg/dL y anti-TPO 650 UI/mL. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Levotiroxina 1,6 mcg/kg/día y atorvastatina desde hoy
B) Levotiroxina 50 mcg/día en ayunas y control de TSH en 6 a 8 semanas
C) Repetir TSH y T4 libre en 3 meses antes de tratar
D) Solicitar ecografía y punción tiroidea antes de tratar
E) Levotiroxina 50 mcg/día y control de TSH en 2 semanas

Respuesta B. Hipotiroidismo primario clínico por Hashimoto (TSH > 10, T4L baja, bocio firme, anti-TPO alto). Por su edad se parte con 50 mcg/día en ayunas y se controla la TSH a las 6–8 semanas. La hipercolesterolemia es secundaria y se corrige con levotiroxina, sin estatinas de entrada.

Pregunta de práctica

Primigesta de 28 años, embarazo de 8 semanas confirmado por ecografía, en su primer control prenatal en el CESFAM. TSH 5,2 mUI/L con T4 libre 1,1 ng/dL (normal). Asintomática, PA 115/70 mmHg, examen segmentario normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Observar, porque la T4 libre es normal, y repetir la TSH en el tercer trimestre
B) Iniciar levotiroxina 50 mcg/día y controlar TSH en 4 semanas
C) Iniciar propiltiouracilo
D) Solicitar ecografía tiroidea antes de decidir
E) Iniciar levotiroxina después del primer trimestre para evitar teratogenia

Respuesta B. En el primer trimestre la meta es TSH < 2,5. Una TSH de 5,2 con T4L normal es un hipotiroidismo subclínico gestacional, que se trata: el cerebro fetal depende de la T4 materna en las primeras 12 semanas. Levotiroxina 50 mcg/día y TSH en 4 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 105 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 84 años se realiza una TSH, que resulta 8,4 UI/L. La TSH se repita 3 meses después, resultando 9,2 UI/L. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar propiltiouracilo oral
B) Iniciar levotiroxina oral 25 ug/día
C) Iniciar tiamazol
D) Iniciar corticoides orales
E) Iniciar levotiroxina oral 75 ug/día

Respuesta B. Tiene un hipotiroidismo subclínico o clínico (no daban la T4 libre, por lo que no se puede saber). Sin embargo, de las opciones, la única que tenía sentido era iniciar levotiroxina y, por ser una adulto mayor, se debe iniciar con una dosis más baja.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 172 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años consulta por astenia, adinamia, malestar general de un año de evolución, aumento de 8 kg de peso, sensación de frío, constipación y mialgias. Al examen: lentitud en lenguaje y razonamiento, piel seca y fría, vitíligo en cara y manos, alopecia moderada, FC 60 lpm, PA 130/80 mmHg, edema bilateral de extremidades inferiores sin fóvea. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Hemograma - VHS
B) Colonoscopía
C) Niveles de cortisol
D) TAC de cerebro
E) TSH

Respuesta E. Hipotiroidismo severo: En sospecha de hipotiroidismo, el examen inicial es la TSH (idealmente con T4 libre). El cuadro clínico con bradicardia, mixedema, piel seca, constipación, aumento de peso y lentitud psicomotora es altamente sugerente de hipotiroidismo severo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 136 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 64 años consulta por astenia y mialgias de 3 meses de evolución. Se solicita TSH, que resulta 5,6 UI/L y T4 libre, que resulta 1,2 ug/ml (Valor Normal: 0,95 a 1,75 ug/ml). La conducta más adecuada es:

A) Solicitar ecografía cervical
B) Iniciar levotiroxina
C) Solicitar TSH y T4 libre en 3 meses
D) Indicar punción tiroidea
E) Solicitar cintigrafía tiroidea

Respuesta C. Es una pregunta muy discutible, ya que el diagnóstico es un hipotiroidismo subclínico y el manejo de esta patología está llena de controversias. Los niveles de TSH y T4 libre de este paciente no justifican los síntomas. Lo más correcto sería seguir estudiando la causa de la astenia y mialgias. Dentro de las opciones, sería válida iniciar tratamiento, si la pregunta se refiere a un hipoT4 sintomáti

1.03.1.003 Hipertiroidismo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio) · Tema 7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos · Tema 7.7 Manejo Terapéutico Comparado: Fármacos, Radioyodo y Cirugía · Tema 7.8 Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica: baja de peso con apetito conservado, intolerancia al calor, temblor fino, taquicardia, palpitaciones, insomnio y polidefecación; en el adulto mayor puede ser apático (fibrilación auricular de novo, insuficiencia cardíaca).
- Diagnóstico: TSH suprimida (<0,01–0,1) con T4 libre alta; si la T4 libre es normal, medir T3 (T3-toxicosis). Graves: bocio difuso con soplo, orbitopatía y mixedema pretibial; TRAb positivos (especificidad >98 %) bastan para confirmarlo.
- Sin TRAb o sin signos típicos: cintigrama. Captación alta difusa (Graves), nódulo caliente (adenoma tóxico) o áreas calientes y frías (bocio multinodular tóxico); captación nula = tiroiditis o hormona exógena, donde los antitiroideos no sirven.
- Inicial: propranolol o atenolol para los síntomas y tiamazol 10–30 mg/día en una toma (PTU solo en el primer trimestre del embarazo y en tormenta); control de T4 libre a las 4–6 semanas.

- Fiebre u odinofagia con tionamidas: suspender y hemograma urgente (agranulocitosis). Seguimiento: derivar a endocrinología para tiamazol 12–18 meses o terapia definitiva (radioyodo, contraindicado en embarazo; cirugía si bocio >80 g, compresivo o sospecha de cáncer).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 149

Mujer de 35 años con exoftalmo bilateral, palpitaciones, pérdida de peso y temblor fino en manos. TSH suprimida, T4 libre elevada. Bocio difuso. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Enfermedad de Graves-Basedow
B) Tiroiditis de Hashimoto
C) Bocio multinodular tóxico
D) Adenoma tóxico de tiroides
E) Tiroiditis subaguda de De Quervain

Respuesta A. Hipertiroidismo con bocio difuso y exoftalmo en una mujer joven: enfermedad de Graves-Basedow. La orbitopatía es patognomónica; el bocio multinodular y el adenoma tóxico son de adultos mayores y rara vez la tienen.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 35

Una paciente presenta un cuadro de 2 meses de evolución de sensación de calor mayor al habitual y sudoración. Se palpa su tiroides de tamaño normal y no presenta exoftalmo. Se solicitan pruebas tiroideas que demuestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 3,9 ng/ml. **¿Cuál es el examen de elección para determinar el diagnóstico etiológico?**

A) Captación de yodo 131
B) Ecografía de tiroides
C) Punción aspirativa con aguja fina de tiroides
D) Cintigrafía tiroidea
E) Anticuerpos antitiroglobulina

Respuesta D. Hipertiroidismo sin bocio ni exoftalmo: la clínica no da la causa. El cintigrama tiroideo muestra el patrón de captación (difusa en Graves, nódulo caliente en el adenoma tóxico, áreas calientes y frías en el BMNT, nula en tiroiditis o facticia).

Pregunta de práctica

Hombre de 68 años con fibrilación auricular, usuario de amiodarona hace 2 años, sin bocio ni enfermedad tiroidea previa. Consulta por palpitaciones y baja de 4 kg. TSH 0,02 mUI/L, T4 libre 2,8 ng/dL. Eco-Doppler: tiroides de tamaño normal, sin vascularización. Captación de yodo nula. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Tiamazol a dosis altas
B) Prednisona 40 mg al día
C) Radioyodo en dosis terapéutica
D) Levotiroxina 50 μg al día
E) Tiroidectomía total de urgencia

Respuesta B. Tiroides previamente normal, Doppler avascular y captación nula: tirotoxicosis por amiodarona tipo 2, una tiroiditis destructiva. Se trata con corticoides (prednisona 40 mg/día). El tiamazol a dosis altas es el tratamiento del tipo 1 (Jod-Basedow, con bocio previo y glándula hipervascular).

Pregunta de práctica

Mujer de 30 años con enfermedad de Graves, en tratamiento con tiamazol 20 mg/día y propranolol hace 5 semanas. Consulta en urgencia por 1 día de fiebre de 39 °C y dolor faríngeo intenso. Faringe eritematosa con exudado amigdalino. FC 104 lpm. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Amoxicilina oral y control en 48 horas, manteniendo el tiamazol
B) Cambiar el tiamazol por propiltiouracilo
C) Suspender el tiamazol y solicitar hemograma urgente con recuento absoluto de neutrófilos
D) Aumentar el tiamazol a 40 mg/día por probable descompensación
E) Paracetamol y continuar el tratamiento sin cambios

Respuesta C. Fiebre y odinofagia en un paciente con tionamidas en los primeros 90 días: sospecha de agranulocitosis. Se suspende el fármaco de inmediato y se pide hemograma urgente; si el RAN es menor a 500/μL, hospitalización en aislamiento, antibióticos y G-CSF. No se cambia a PTU por reactividad cruzada.

Pregunta de práctica

Mujer de 34 años con enfermedad de Graves que recae 6 meses después de completar 18 meses de tiamazol. No fuma y no tiene orbitopatía. Tiroides de 35 g sin nódulos. Planea su primer embarazo el próximo año. Se decide tratamiento con radioyodo. **¿Cuál es la indicación más importante asociada a esta terapia?**

A) Prednisona profiláctica por 6 semanas
B) Beta-hCG negativa antes de la dosis y anticoncepción eficaz por al menos 6 meses
C) Solución de Lugol 7 a 10 días antes del radioyodo
D) Suspender el radioyodo y reiniciar tiamazol hasta después del embarazo
E) Evitar la levotiroxina después del tratamiento para no interferir con el embarazo

Respuesta B. Recidiva de Graves sin orbitopatía ni bocio compresivo: el radioyodo es una buena opción. Por el deseo de embarazo, lo fundamental es descartar embarazo actual (beta-hCG negativa) y asegurar anticoncepción al menos 6 meses después de la dosis. La prednisona profiláctica es para la orbitopatía activa; el Lugol es la preparación de la cirugía.

Pregunta de práctica

Paciente de 38 años con enfermedad de Graves y bocio difuso de 120 g con compresión traqueal sintomática, programado para tiroidectomía total. Está eutiroideo con tiamazol 20 mg/día. Se busca reducir la vascularización glandular y el sangrado operatorio. **¿Cuál es la medida farmacológica recomendada en los 7 a 10 días previos a la cirugía?**

A) Solución de Lugol oral, 3 a 5 gotas cada 8 horas
B) Suspender el tiamazol e iniciar propiltiouracilo a dosis altas
C) Una dosis baja de radioyodo 48 horas antes de la incisión
D) Anticoagulación plena con heparina de bajo peso molecular
E) Carbonato de litio para aumentar la captación de hormonas

Respuesta A. La solución de Lugol (o SSKI) 7 a 10 días antes de la tiroidectomía produce el efecto Wolff-Chaikoff transitorio y disminuye el flujo sanguíneo glandular, reduciendo el riesgo de tormenta y de hemorragia intraoperatoria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Era una clínica de ojo rojo, pero con temblor en las manos y baja de peso, al examen físico se observa retracción palpebral: a. TSH y T4 libre

A) Accidente cerebrovascular
B) Epilepsia
C) Esclerosis múltiple
D) Enfermedad de Parkinson
E) Migraña

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Accidente cerebrovascular). Los trastornos ansiosos incluyen el trastorno de pánico (o angustia), el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, la fobia social, las fobias simples, el TOC, el trastorno de estrés postraumático (TEPT), el estrés agudo y el trastorno adaptativo. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de

1.03.1.004 Cáncer del tiroides

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.10 Cáncer de Tiroides: Subtipos Histológicos y Manejo Oncológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante nódulo tiroideo con factores de riesgo: radioterapia cervical en la infancia, familiar con carcinoma medular o NEM 2, crecimiento rápido, disfonía (parálisis de cuerda vocal), nódulo duro o adenopatías cervicales duras y fijas.
- Papilar (85–90 %, diseminación linfática, excelente pronóstico) y folicular (5–10 %, hematógena a pulmón y hueso, la PAAF no lo diagnostica) son los diferenciados; medular (células C, calcitonina y CEA, 25 % hereditario por RET); anaplásico (adulto mayor, masa pétrea que crece en semanas con disfonía, disfagia y estridor).
- Estudio inicial: TSH y ecografía cervical (nódulo y ganglios), PAAF guiada según TI-RADS; Bethesda IV, V o VI obligan a derivar.
- Tratamiento por especialista: tiroidectomía total (o lobectomía en papilar unifocal de bajo riesgo), radioyodo según riesgo y levotiroxina con TSH frenada; en el medular descartar feocromocitoma antes de operar.
- GES cáncer de tiroides diferenciado y medular desde los 15 años. Seguimiento: derivar; luego levotiroxina de por vida y control con tiroglobulina + anti-Tg (diferenciado) o calcitonina (medular) y ecografía de cuello.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 74 años consulta por una masa cervical anterior que notó hace 4 semanas y que ha crecido rápidamente. Refiere disfonía, dificultad para tragar y en las últimas horas ruido al respirar. Al examen se palpa una masa tiroidea de 6 cm, pétrea, fija a planos profundos, con estridor inspiratorio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Carcinoma papilar de tiroides
B) Carcinoma folicular de tiroides
C) Carcinoma anaplásico de tiroides
D) Bocio multinodular
E) Tiroiditis subaguda de De Quervain

Respuesta C. Adulta mayor con masa pétrea y fija que crece en semanas e invade nervio recurrente, esófago y tráquea (disfonía, disfagia, estridor): carcinoma anaplásico, 1–2 % de los casos, con sobrevida media de 3 a 6 meses. El papilar y el folicular crecen lento y afectan a pacientes más jóvenes.

1.03.1.005 Tiroiditis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 1.5 Tiroiditis: Hashimoto, De Quervain (Subaguda), Silente y Fármacos (Amiodarona, Litio)

QUÉ HAY QUE SABER

- De Quervain (subaguda): 1–3 semanas tras una infección respiratoria; dolor cervical intenso irradiado a mandíbula y oídos, tiroides dolorosa, VHS >60–100 mm/h y captación de yodo casi nula (<1–2 %).
- Evolución de las destructivas en tres fases: tirotóxica (semanas 1–6), hipotiroidea (6–16) y recuperación en más del 90 % a los 4–6 meses.
- Tratamiento de De Quervain: AINE (ibuprofeno o naproxeno); prednisona 30–40 mg/día con descenso en 4–6 semanas si es refractaria; propranolol para palpitaciones y temblor. El tiamazol no sirve (no hay síntesis).
- Silente o posparto: indolora, anti-TPO positivos en 50–70 %; propranolol en la fase tóxica y levotiroxina transitoria si hay hipotiroidismo sintomático. Hashimoto: bocio firme indoloro, levotiroxina de por vida según TSH. Supurada: fluctuación y leucocitosis, drenaje y antibióticos EV.
- Amiodarona tipo 1 (bocio previo, Doppler vascular): tiamazol; tipo 2 destructiva (captación nula): prednisona 40 mg/día. Litio: mantenerlo y agregar levotiroxina. Seguimiento: TSH seriada hasta la recuperación y luego anual en las posparto (riesgo de hipotiroidismo definitivo).

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 30

Una paciente de 23 años, consulta por malestar general y sensación febril de una semana de evolución, asociado a artralgias y palpitaciones. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L (valor normal: 0,3-4,5 UI/L), T4L: 1,9 ng/mL (valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (valor normal: 20% a 30%). **¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?**

A) Tiamazol
B) AINEs
C) Propiltiouracilo
D) Bloqueadores beta
E) Yodo radioactivo en dosis terapéutica

Respuesta B. Tiroides dolorosa, febrícula, tirotoxicosis y captación del 2 %: tiroiditis subaguda de De Quervain. Se trata con AINE. Los antitiroideos no sirven y el radioyodo no capta. El betabloqueo alivia los síntomas, pero no es el tratamiento de la enfermedad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 10

Una paciente de 33 años, consulta por dolor cervical intenso de una semana de evolución asociado a sensación febril. Al examen físico destaca glándula tiroides del doble del tamaño normal, muy dolorosa a la palpación, frecuencia cardiaca de 90 latidos por minuto y presión arterial de 120/80 mm Hg. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,2 UI/L, T4L: 1,9 ng/mL (Valor normal: 0,6-1,7 ng/mL), captación de yodo radioactivo de 2% (Valor normal: mayor a 3%). **¿Cuál es el tratamiento de elección en esta paciente?**

A) Propiltiouracilo
B) Ibuprofeno
C) Prednisona
D) Levotiroxina
E) Yodo radioactivo

Respuesta B. Tiroiditis subaguda de De Quervain: la primera línea es un AINE como el ibuprofeno. La prednisona se reserva para el dolor muy intenso o refractario a AINE. No se usan antitiroideos ni radioyodo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 114

Una paciente de 30 años, usuaria de anticonceptivos orales, consulta por cuadro de 8 días de sudoración, palpitaciones e insomnio, que durante los últimos días se ha asociado a dolor en región cervical anterior. Al examen físico se aprecia con frecuencia cardiaca de 100 por minuto, presión arterial 140/90, dolor a la palpación cervical. Se solicitan exámenes donde destaca T4 y T4L aumentadas y TSH suprimida, electrocardiograma normal. **El tratamiento de elección en este caso es:**

A) Propiltiouracilo
B) Paracetamol
C) Metimazol
D) Ketoprofeno
E) Enalapril

Respuesta D. Tirotoxicosis con dolor cervical anterior: tiroiditis subaguda de De Quervain. Se trata con un AINE (ketoprofeno). El paracetamol no tiene efecto antiinflamatorio suficiente y los antitiroideos no están indicados.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 115

Una paciente usuaria de anticonceptivos y con antecedentes familiares de hipotiroidismo, consulta por aumento de volumen en el cuello. Al examen físico, la tiroides se palpa aumentada de tamaño, sin nódulos. Los exámenes revelan una TSH: 2,0 UI/L, T4: 14,0 ug/dl (valor normal: 4,5 a 9,5), anticuerpos antitiroglobulina: 48 UI/ml (valor normal: <35) y anticuerpos antiperoxidasa tiroidea: 320 UI/ml (valor normal: <35). **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar T4 libre
B) Solicitar ecografía tiroidea
C) Solicitar una cintigrafía tiroidea
D) Realizar control de TSH y T4 en un año
E) Realizar biopsia tiroidea por punción

Respuesta D. Bocio difuso con antiperoxidasa muy elevados y TSH normal: tiroiditis de Hashimoto eutiroidea. La T4 total alta se explica por los anticonceptivos, que elevan la proteína transportadora; la TSH normal descarta hipertiroidismo. Se controla la función tiroidea en forma anual para pesquisar el hipotiroidismo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 160 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente consulta por un cuadro de 3 semanas de evolución de fiebre, sudoración nocturna, temblor, malestar general y artralgias. Hace 7 días se agrega dolor en el cuello. Al examen físico tiene marcado dolor a la palpación de la glándula tiroides. Se solicitan exámenes que muestran TSH: 0,01 UI/L y T4 libre: 2,9 ng/dl, con captación de yodo radiactivo de 1% (VN: 2 a 40%). El tratamiento más adecuado es:

A) Paracetamol
B) Antibióticos
C) Prednisona
D) Metimazol
E) Ketoprofeno

Respuesta E. Tiene una clásica tiroiditis subaguda o tiroiditis de Quervain, que se trata con AINEs. Solo si es que tiene muchos síntomas hipertiroideos se agrega el propanolol. No están indicadas las drogas antitiroideas (metimazol o propiltiouracilo).

1.03.1.006 Síndrome de Cushing

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.11 Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más frecuente: exógena (corticoides orales, inyectables, tópicos o inhalados). Endógena ACTH-dependiente 80–85 % (enfermedad de Cushing por microadenoma hipofisario 70–75 %, ACTH ectópica 10 %) o independiente (adenoma suprarrenal 10 %, carcinoma).
- Signos más específicos: equimosis fáciles, estrías violáceas anchas (>1 cm), miopatía proximal y plétora facial; acompañan obesidad central, cara de luna, giba, HTA resistente, diabetes, osteoporosis e hirsutismo.
- Tamizaje (descartada causa exógena y pseudo-Cushing por depresión, alcohol u obesidad mórbida): test de Nugent (dexametasona 1 mg a las 23 h, cortisol 8 h normal <1,8 mcg/dL), cortisol libre urinario de 24 h o cortisol salival nocturno; se confirma con 2 pruebas alteradas. El cortisol matinal aislado no sirve.
- Recién confirmado: ACTH plasmática; suprimida, TC de suprarrenales; normal o alta, RM de silla turca. ACTH ectópica: cuadro fulminante con hipokalemia, hiperpigmentación y ACTH >100 en fumador.
- No es GES: derivar con prioridad a endocrinología (cirugía transesfenoidal o suprarrenalectomía, luego hidrocortisona por 6–12 meses). Inicial: controlar HTA, diabetes e hipokalemia, prevenir trombosis e infecciones.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 27

Una paciente de 13 años, sin antecedentes, consulta por cefalea e hirsutismo. Al examen físico se encuentra presión arterial en percentil 99 para su edad, índice de masa corporal mayor al percentil 95 para su edad, acné inflamatorio en su rostro y estrías abdominales. **El diagnóstico más probable es:**

A) Diabetes mellitus tipo 2
B) Síndrome de ovario poliquístico
C) Síndrome de Cushing
D) Hipotiroidismo
E) Hiperprolactinemia

Respuesta C. Obesidad, hipertensión marcada, estrías, hirsutismo y acné: el conjunto corresponde a un síndrome de Cushing. El ovario poliquístico explica el hirsutismo y el acné, pero no la hipertensión severa con estrías.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 169

Una mujer de 34 años, con amenorrea de 6 meses, presenta un cuadro de astenia y malestar general. Además refiere equimosis ante mínimos traumatismos. Actualmente tiene PA: 150/90 mmHg, acné facial, cuello ancho, obesidad centrípeta y estrías violáceas. Tiene prueba de embarazo negativa. **¿Cuál es la prueba a realizar en primer lugar?**

A) Cortisol plasmático basal
B) FSH y estradiol plasmático
C) Cortisol libre urinario
D) Prueba de estimulación con ACTH
E) Resonancia magnética de silla turca

Respuesta C. Equimosis fáciles, estrías violáceas, obesidad centrípeta e hipertensión: sospecha de Cushing. El estudio parte con una prueba de primera línea, como el cortisol libre urinario de 24 horas. El cortisol basal no sirve, la estimulación con ACTH es para la insuficiencia suprarrenal y la resonancia va después.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 159

Una paciente de 29 años consulta por aumento de peso de 10 kg en un año, a pesar de seguir una dieta. Refiere también que sus reglas se han vuelto irregulares y cada vez son menos frecuentes. En su examen físico se observa obesidad y estrías en el abdomen y los muslos, de color rojizo. Sus signos vitales muestran FC: 72 lpm y PA: 150/96 mmHg. **¿Cuál de los siguientes exámenes es más adecuado para iniciar el estudio de esta paciente?**

A) Cortisol plasmático a las 7:00 y a las 23:00 horas
B) Cortisol plasmático post-dexametasona
C) Niveles plasmáticos de ACTH
D) Resonancia magnética nuclear de abdomen
E) Resonancia magnética nuclear de hipófisis

Respuesta B. El estudio del Cushing se inicia con una prueba de primera línea: cortisol libre urinario, test de supresión con 1 mg de dexametasona o cortisol salival. La ACTH y las imágenes van después de confirmar el hipercortisolismo.

Pregunta de práctica

Mujer de 41 años, sin uso de corticoides, con obesidad central, estrías violáceas de 1,5 cm y miopatía proximal. Test de Nugent: cortisol 8 h de 12 mcg/dL. Cortisol libre urinario de 24 h: 5 veces el límite superior. ACTH plasmática matinal: indetectable (menor de 2 pg/mL). **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el estudio?**

A) Resonancia magnética de silla turca con gadolinio
B) Tomografía computarizada de abdomen con protocolo suprarrenal
C) Cateterismo de senos petrosos inferiores
D) Test de estimulación con ACTH sintética
E) Tomografía computarizada de tórax

Respuesta B. El hipercortisolismo está confirmado con dos pruebas de primera línea alteradas. La ACTH suprimida indica un Cushing ACTH-independiente: el origen es suprarrenal, y la imagen que corresponde es la TC de abdomen con protocolo suprarrenal. La RM de silla turca y el cateterismo se reservan para el Cushing ACTH-dependiente.

Pregunta de práctica

Un hombre de 62 años, fumador pesado de 40 paquetes/año, consulta por astenia severa, debilidad muscular profunda, edema de extremidades inferiores y pérdida de 8 kg de peso en el último mes. Destaca hiperpigmentación cutánea difusa, PA 175/105 mmHg, sin obesidad evidente. Glicemia 260 mg/dL, potasio 2,1 mEq/L y bicarbonato 36 mEq/L. Se confirma hipercortisolismo con ACTH plasmática de 280 pg/mL. El test con dexametasona 8 mg no suprime el cortisol. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Enfermedad de Cushing por adenoma hipofisario
B) Carcinoma de la corteza suprarrenal productor de cortisol
C) Síndrome de Cushing ectópico secundario a carcinoma pulmonar de células pequeñas (oat cell)
D) Hiperaldosteronismo primario (Síndrome de Conn)
E) Insuficiencia suprarrenal primaria por metástasis

Respuesta C. ACTH muy elevada que no suprime con 8 mg de dexametasona, en un fumador con cuadro rápido, hipokalemia con alcalosis metabólica e hiperpigmentación: Cushing ectópico por carcinoma pulmonar de células pequeñas. La rapidez explica que no alcance el fenotipo cushingoide.

Pregunta de práctica

Una paciente de 41 años con Síndrome de Cushing confirmado presenta una ACTH plasmática indetectable (< 2 pg/mL). La TC de abdomen revela un tumor suprarrenal derecho de 3.2 cm homogéneo con baja atenuación (< 10 Unidades Hounsfield) compatible con adenoma benigno; la glándula suprarrenal izquierda luce de aspecto atrófico y delgada. La paciente es sometida exitosamente a una suprarrenalectomía laparoscópica derecha. **En el postoperatorio inmediato, ¿cuál es la medida farmacológica mandatoria que debe iniciarse para prevenir una complicación potencialmente mortal?**

A) Iniciar ketoconazol oral para bloquear residuos tumorales
B) Iniciar terapia de reemplazo hormonal con Hidrocortisona por riesgo inminente de crisis suprarrenal secundaria a la atrofia del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal contralateral
C) Indicar espironolactona a dosis altas para prevenir hiperkalemia
D) Indicar radioyodo I-131 para destruir remanentes glandulares
E) Mantener en observación sin medicamentos puesto que la glándula contralateral asumirá de inmediato la función fisiológica

Respuesta B. El cortisol autónomo del adenoma suprimió por años la ACTH, y la suprarrenal contralateral está atrófica. Al extirpar el adenoma, la paciente cae en insuficiencia suprarrenal aguda: se inicia hidrocortisona de inmediato y se mantiene 6 a 12 meses, hasta que el eje se recupere.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 18 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años aumento de peso de 5 meses de evolución, asociado a malestar general. Refiere importante astenia, que ha progresado y debilidad muscular. Al examen físico presenta PA: 150/100 mmHg, atrofia de las masas musculares de las extremidades, obesidad abdominal y piel con estrías vinosas en la pared abdominal e hirsutismo en cara, abdomen y pecho. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio en este paciente?

A) Niveles de ACTH plasmático matinal y vespertino
B) 17 hidroxiprogesterona
C) TAC de silla turca
D) Cortisol libre urinario de 24 horas
E) Prueba de estimulación con ACTH

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Cortisol libre urinario de 24 horas). El síndrome de Cushing se estudia de elección con el cortisol libre urinario de 24 horas.. El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 43 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 16 años, obesa, consulta por astenia y debilidad de semanas de evolución, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se corrobora obesidad en percentil 97 para la edad, se aprecia hirsutismo, acné inflamatorio y estrías abdominales. El diagnóstico más probable es:

A) Resistencia insulínica
B) Síndrome de ovario poliquístico
C) Síndrome de Cushing
D) Diabetes Mellitus tipo 1
E) Hiperprolactinoma

Respuesta C. Diagnóstico: Síndrome de Cushing (opción C). Es la misma pregunta de antes.. El hipotiroidismo en el embarazo es importante porque se asocia a daño en el desarrollo cerebral del feto. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

1.03.1.007 Insuficiencia suprarrenal crónica

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.12 Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Primaria (Addison): destrucción de la corteza, autoinmune en 70–80 % (también TBC, metástasis, hemorragia); falta cortisol y aldosterona, con ACTH muy alta, hiperpigmentación (pliegues palmares, mucosa oral, cicatrices) e hiperkalemia.
- Secundaria: falta de ACTH; la causa más frecuente es la suspensión brusca de corticoides (también tumores selares, apoplejía, radioterapia); piel pálida y potasio normal.
- Sospecha: astenia, baja de peso, náuseas, hipotensión ortostática, hipoglicemia e hiponatremia de meses de evolución.
- Confirmación: cortisol plasmático a las 8 h <3 mcg/dL confirma, >15–18 lo descarta; entre 3 y 15, test de Synacthen 250 mcg (pico <18 confirma). La ACTH separa primaria (alta) de secundaria (baja).
- Inicial: hidrocortisona 15–25 mg/día en 2–3 tomas (10–5–2,5 mg) y, solo en Addison, fludrocortisona 0,05–0,1 mg/día; educar: duplicar o triplicar dosis ante fiebre o infección y hidrocortisona 100 mg IM si hay vómitos. Seguimiento: derivar a endocrinología; ajustar por clínica, PA y electrolitos, nunca por cortisol.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 112

Un paciente alcohólico, vagabundo, con antecedente de haber sido tratado por tuberculosis hace dos años, consulta por un cuadro de diarrea y baja de peso, malestar general de algunos meses de evolución. En su examen físico se aprecia IMC de 16, hiperpigmentación de pliegues y melanoplaquias. En sus exámenes tiene K: 5,5 mEq/L, Na: 132 mEq/L. **El diagnóstico más probable es:**

A) Síndrome paraneoplásico
B) Desnutrición proteica
C) Enfermedad de Addison
D) Cáncer de sitio no precisado
E) Pancreatitis crónica

Respuesta C. Hiperpigmentación de pliegues, melanoplaquias, hiperkalemia e hiponatremia: insuficiencia suprarrenal primaria, probablemente por tuberculosis suprarrenal, que es la segunda causa después de la autoinmune.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 102

Un paciente alcohólico, en situación de calle, con antecedente de una tuberculosis tratada hace 2 años, consulta por astenia de 3 meses de evolución, asociada a debilidad muscular, dolor abdominal y diarrea. Al examen físico tiene FC 110 lpm, PA 90/60 mmHg y presenta hiperpigmentación en los pliegues y melanoplaquias. Entre sus exámenes destaca creatinina 1,0 mg/dl, sodio 131 mEq/L, potasio 5,6 mEq/L, cloro 94 mEq/L, hematocrito 35% y blancos 7.500 por mm³. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome paraneoplásico
B) Cáncer de origen desconocido
C) Enfermedad de Addison
D) Daño hepático crónico
E) Tuberculosis renal

Respuesta C. Astenia, hipotensión, síntomas digestivos, hiperpigmentación de pliegues y mucosas, hiponatremia e hiperkalemia: insuficiencia suprarrenal primaria (Addison). El antecedente de tuberculosis apunta a la segunda causa más frecuente, después de la autoinmune. La hiperpigmentación se debe a la ACTH elevada.

Pregunta de práctica

Un hombre de 42 años acude por debilidad marcada, náuseas recurrentes, baja de 6 kg de peso e hipotensión arterial. Destaca hiperpigmentación marcada en surcos de las manos, codos y encías. Na 129 mEq/L, K 5,8 mEq/L y glicemia 70 mg/dL. Cortisol basal 8 h: 2,0 mcg/dL con ACTH plasmática de 180 pg/mL (VN < 50). **¿Cuál es el tratamiento sustitutivo crónico de elección que debe prescribirse?**

A) Hidrocortisona oral en monoterapia
B) Prednisona oral asociada a espironolactona
C) Hidrocortisona oral asociada obligatoriamente a Fludrocortisona oral
D) Dexametasona oral en dosis nocturna única
E) Fludrocortisona oral en monoterapia sin glucocorticoides

Respuesta C. Cortisol menor de 3 mcg/dL con ACTH elevada, hiperpigmentación e hiperkalemia: enfermedad de Addison. Falta cortisol y aldosterona, así que el reemplazo es hidrocortisona 15–25 mg/día repartida más fludrocortisona 0,05–0,1 mg/día.

Pregunta de práctica

Una mujer de 58 años con artritis reumatoide, en tratamiento con prednisona 15 mg diarios durante 2 años, suspende bruscamente el fármaco. A los 5 días consulta por debilidad extrema, náuseas, astenia e hipotensión postural (PA 95/60 mmHg). Piel pálida sin hiperpigmentación. Na 131 mEq/L, K 4,2 mEq/L, ACTH 4 pg/mL y cortisol 2,1 mcg/dL. **¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico principal que explica este cuadro?**

A) Destrucción autoinmune aguda de la glándula suprarrenal
B) Supresión exógena prolongada del eje hipotálamo-hipófisis con atrofia corticosuprarrenal secundaria y déficit exclusivo de glucocorticoides con aldosterona preservada
C) Falla mineralocorticoide primaria con pérdida renal masiva de potasio
D) Secreción ectópica de péptidos supresores adrenales
E) Síndrome de lisis corticosuprarrenal por nefropatía intersticial

Respuesta B. El corticoide exógeno por años frenó la CRH y la ACTH (ACTH de 4 pg/mL) y atrofió la corteza. Al suspenderlo, falta cortisol, pero la glomerulosa depende del sistema renina-angiotensina: la aldosterona está preservada, por eso el potasio es normal y no hay hiperpigmentación.

1.03.1.008 Hirsutismo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.2 Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP): Criterios de Rotterdam, Resistencia a la Insulina y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Hirsutismo: vello terminal de distribución masculina en la mujer (Ferriman-Gallwey ≥8); la causa más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico (SOP), seguido del hirsutismo idiopático.
- SOP por criterios de Rotterdam (2 de 3): oligo o anovulación (ciclos >35 días), hiperandrogenismo clínico o bioquímico y morfología poliquística en la ecografía; se asocia a resistencia a la insulina.
- Descarte obligatorio: 17-hidroxiprogesterona (hiperplasia suprarrenal no clásica), TSH y prolactina. Banderas rojas de tumor productor de andrógenos o Cushing: virilización (clitoromegalia, voz grave, calvicie), inicio rápido, testosterona o DHEA-S muy elevadas.
- Inicial: estilo de vida (bajar 5–10 % del peso restablece la ovulación en más de la mitad); sin deseo de embarazo, anticonceptivos combinados con progestágeno antiandrogénico (ciproterona, dienogest o drospirenona), metformina si hay resistencia a la insulina y espironolactona si persiste el hirsutismo; medidas cosméticas.
- Seguimiento completo por el médico general: respuesta a 6 meses de tratamiento, control metabólico (glicemia, lípidos) y protección endometrial en la anovulación crónica; con deseo de embarazo, letrozol (derivar). Derivar si hay virilización o sospecha de tumor.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 115

Una paciente de 17 años, con menarquia a los 16 años, tiene reglas cada 3 a 4 meses. Presenta vello grueso en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey mayor a 15. Su examen mamario y genital son normales. **¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?**

A) Relación FSH sobre LH
B) Cariograma
C) Curva de insulina
D) Niveles plasmáticos de prolactina
E) Diecisiete hidroxiprogesterona

Respuesta E. El cuadro es compatible con hiperandrogenismo severo, y el diagnóstico diferencial obligatorio del ovario poliquístico es la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, que se descarta midiendo la 17-hidroxiprogesterona.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 17 años, con antecedente se haber tenido su menarquia a los 16 años, con reglas que ocurren cada 3 a 4 meses. Tiene hirsutismo en el mentón, los brazos, el pecho, los muslos y la línea media abdominal, tanto infraumbilical, como supraumbilical, con un índice de Ferriman-Gallwey > 15. ¿Cuál es el examen de elección para hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome de ovario poliquístico?

A) Relación FSH/LH
B) Cariograma
C) Curva de insulina
D) Prolactina
E) 17-hidroxi-progesterona

Respuesta E. [Pregunta disputada] No se entiende qué es lo que se quería pregunta. La 17-OH progesterona permite diagnosticar la hiperplasia suprarrenal congénita, que es el diagnóstico diferencial del SOP más importante y que también tiene mucho hirsutismo. Por otro lado, la relación LH/FSH elevada sugiere un SOP, aunque no se usa como criterio, por tener muchos falsos negativos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 115 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 17 años, con IMC de 34, presenta oligomenorrea, desde su primera mesntruación. Además tiene acné y se observa hirsutismo en la cara, los pezones e intermamario. ¿Qué examen es el más adecuado para confirmar el diagnóstico?

A) Testosterona plasmática
B) Andrógenos totales
C) Prueba de progesterona
D) Índice de andrógenos libres
E) 17 hidroxiprogesterona

Respuesta D. Tiene un SOP ya diagnosticado (cumple 2 criterios: oligomenorrea y el hiperandrogenismo cínico), por tanto no es necesario pedir ningún examen. No aparecía como alternativa, así que hay que pedir índice de andrógenos libres, que es el examen de eleción para evaluar el hiperandrogenismo en el SOP).

1.03.1.009 Hipertensión arterial de origen endocrino

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.14 Hiperaldosteronismo Primario (Síndrome de Conn) e HTA Secundaria · Tema 7.15 Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar HTA endocrina en: HTA resistente (3 fármacos incluido diurético), HTA con hipokalemia, inicio antes de los 35–40 años, crisis paroxísticas, incidentaloma suprarrenal o fenotipo cushingoide.
- Hiperaldosteronismo primario: HTA con hipokalemia y alcalosis; tamizaje con relación aldosterona/renina (RAR >20–30 con aldosterona >15, corrigiendo antes el potasio y suspendiendo espironolactona); se confirma con sobrecarga salina y luego TC.
- Feocromocitoma: crisis de cefalea, sudoración y palpitaciones con HTA; examen de elección: metanefrinas plasmáticas o urinarias de 24 h, luego imagen. Nunca betabloqueo antes del bloqueo alfa.
- Otras: Cushing (Nugent o cortisol libre urinario), hipertiroidismo (TSH), hiperparatiroidismo (calcemia) y acromegalia.
- Inicial: controlar la PA (espironolactona en hiperaldosteronismo; doxazosina o fenoxibenzamina en feocromocitoma). Derivar a endocrinología: adenoma de Conn unilateral y feocromocitoma se operan; la hiperplasia bilateral se trata con espironolactona o eplerenona de por vida.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 45

Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia, debilidad muscular y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico se observa obeso, con PA: 170/100 mmHg, FC: 70 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K: 2.6 mEq/L, Cl:100 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. **La causa más probable de la hipertensión es:**

A) Hipertensión renovascular
B) Feocromocitoma
C) Hipotiroidismo
D) Hiperaldosteronismo primario
E) Hipertensión esencial

Respuesta D. Hipertensión con hipokalemia marcada y síntomas de hipokalemia (calambres, debilidad, cefalea): hiperaldosteronismo primario clásico. La renovascular también puede dar hipokalemia por hiperaldosteronismo secundario, pero se sospecha con soplo abdominal o antecedente cardiovascular.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 121

Un paciente de 37 años es diagnosticado de hipertensión hace un año, en tratamiento con enalapril, atenolol e hidroclorotiazida, a pesar de lo cual ha presentado valores tensionales sobre el objetivo, con varias tomas sobre 160/110 mmHg. Además, aqueja astenia, debilidad de las extremidades inferiores y cefalea frecuente. Se solicitan exámenes generales, que muestran TSH: 6,0 UI/L, creatinina: 1,2 mg/dl, sodio: 142 mEq/L, potasio: 3,1 mEq/L, hemograma normal y glicemia de ayuno: 72 mg/dl. Se solicita TAC de abdomen, que muestra un tumor suprarrenal derecho, de 2 cm de diámetro, sólido y homogéneo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Feocromocitoma
B) Hipertensión esencial
C) Hipertensión renovascular
D) Hipertensión asociada a insuficiencia renal
E) Hiperaldosteronismo primario

Respuesta E. Joven, HTA resistente a tres fármacos con diurético, hipokalemia con síntomas y un nódulo suprarrenal pequeño y homogéneo: adenoma productor de aldosterona (Conn). El feocromocitoma daría crisis paroxísticas, no hipokalemia.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 82

Paciente con HTA de difícil control, cefalea, palpitaciones y lesión suprarrenal derecha de 5 cm en TAC. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Adenoma suprarrenal productor de aldosterona
B) Carcinoma suprarrenal
C) Feocromocitoma
D) Quiste suprarrenal simple
E) Hiperplasia suprarrenal nodular

Respuesta C. HTA de difícil control con cefalea y palpitaciones (clínica adrenérgica) y una masa suprarrenal grande: feocromocitoma. El adenoma de Conn da HTA con hipokalemia, sin crisis adrenérgicas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 59

Una paciente de 60 años presenta cefalea, astenia y calambres en extremidades inferiores. Al examen físico destaca PA: 170/95 mmHg, FC: 80 lpm y en sus exámenes destaca Na: 150 mEq/L, K: 2.6 mEq/L, Cl: 90 mEq/L y TSH: 4.0 UI/L. **La causa más probable de la hipertensión es:**

A) Hipertensión renovascular
B) Feocromocitoma
C) Hipotiroidismo
D) Hiperaldosteronismo
E) Hipertensión esencial

Respuesta D. La HTA renovascular también puede dar hipokalemia (hiperaldosteronismo secundario), pero aquí no hay soplo ni alza de creatinina; la hipokalemia marcada con calambres, astenia y sodio alto calza mejor con hiperaldosteronismo primario.

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con hiperaldosteronismo primario confirmado por RAR elevada y test de sobrecarga salina. La TC muestra hiperplasia suprarrenal bilateral. Inició espironolactona 50 mg/día con buen control de presión y potasio normal, pero a los 4 meses consulta por aumento de volumen mamario doloroso bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suprarrenalectomía laparoscópica bilateral
B) Cambiar espironolactona por eplerenona
C) Aumentar espironolactona a 100 mg/día
D) Suspender espironolactona e indicar hidroclorotiazida
E) Solicitar muestreo venoso suprarrenal

Respuesta B. La hiperplasia bilateral se trata de por vida con un antagonista mineralocorticoide. La ginecomastia es el efecto antiandrogénico de la espironolactona: se rota a eplerenona, selectiva. La cirugía bilateral dejaría una insuficiencia suprarrenal permanente, y una tiazida empeoraría la hipokalemia.

Pregunta de práctica

Mujer de 36 años con episodios de cefalea pulsátil intensa, palpitaciones y sudoración profusa de 15 a 30 minutos, 2 a 3 veces por semana desde hace 3 meses. En una crisis en el policlínico se constata PA 210/120 mmHg y FC 130 lpm. Entre las crisis está asintomática. **¿Cuál es el examen inicial más adecuado para confirmar la sospecha?**

A) TC de abdomen con contraste
B) Catecolaminas plasmáticas durante una crisis
C) Metanefrinas fraccionadas en orina de 24 horas
D) Relación aldosterona / renina plasmática
E) Cintigrafía con MIBG

Respuesta C. Tríada paroxística con HTA: sospecha de feocromocitoma. El examen de primera línea son las metanefrinas (plasmáticas o urinarias de 24 h), con sensibilidad > 98 %. La TC y la MIBG localizan, pero solo después de confirmar; las catecolaminas son menos sensibles; la RAR estudia el hiperaldosteronismo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años consulta por cefalea y debilidad muscular de algunos meses de evolución. Al examen físico presenta FC: 70x', PA: 160/110 mmHg, sin otros hallazgos. Se solicitan exámenes que muestran creatininemia de 0,9 mg/dl, sodio: 138 mEq/l, potasio: 3,0 mEq/l y cloro: 98 mEq/l. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio en este paciente?

A) Doppler de arterias renales
B) Holter de presión arterial
C) Determinación de metanefrinas urinarias
D) Relación aldosterona / actividad de renina plasmática
E) Cortisol libre urinario de 24 horas

Respuesta D. Un paciente joven con hipertensión y cefalea, con hipopotasemia y debilidad muscular, tiene una hipertensión secundaria con sospecha de hiperaldosteronismo primario. El estudio de elección es la relación aldosterona/actividad de renina plasmática. Las metanefrinas se piden ante crisis adrenérgicas y el cortisol libre ante rasgos cushingoides, y el Doppler renal se reserva para sospecha de hiperten

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 59 · texto original del banco, sin revisar

Hipertensión renovascular (yo vi 2 hiperaldosteronismos primarios, confirmo x2) habían 2, uno joven con muchos sintomas de hipokalemia (HAP)y la otra era adulto mayor con proteinuria (HTRV)? vs Hiperaldosteronismo primario

A) Ninguna de las anteriores es correcta
B) Todas las anteriores son correctas
C) No se dispone de información suficiente
D) Otra alternativa no descrita
E) Otra alternativa no descrita

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Ninguna de las anteriores es correcta). Clase sobre diagnóstico, objetivos y pilares del tratamiento de la hipertensión arterial. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

1.03.1.010 Amenorrea

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- Amenorrea secundaria: ausencia de regla por 3 meses (o 6 si era irregular). El primer examen siempre es la beta-hCG (embarazo, la causa más frecuente); luego TSH y prolactina.
- Test de progesterona: si sangra hay estrógenos sin ovulación (anovulación, SOP); si no sangra, test de estrógeno + progesterona y FSH: FSH alta = falla ovárica (insuficiencia ovárica prematura si <40 años); FSH baja = hipotalámica o hipofisaria; sin sangrado con estrógenos tras legrado = Asherman.
- Amenorrea primaria (sin menarquia a los 15 años o sin caracteres sexuales a los 13): sin útero, cariotipo (Rokitansky 46,XX con vello normal; Morris 46,XY sin vello); con útero, FSH alta (Turner, talla baja) o baja (Kallmann, anosmia); himen imperforado con dolor cíclico.
- Inicial: cabergolina en hiperprolactinemia, recuperar peso y moderar ejercicio en la amenorrea hipotalámica funcional, levotiroxina si hay hipotiroidismo; terapia hormonal hasta los 50 años en la insuficiencia ovárica prematura.

- Derivar a ginecología o endocrinología: amenorrea primaria, macroprolactinoma con compromiso visual (RM urgente), gónada con cromosoma Y (gonadectomía), Asherman (histeroscopía) e insuficiencia ovárica prematura.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Mujer de 17 años consulta por amenorrea primaria. Al examen: desarrollo mamario Tanner V, con ausencia completa de vello axilar y púbico. La vagina termina en un fondo ciego corto y se palpan masas móviles no dolorosas en ambos conductos inguinales. Está a la espera del resultado del cariotipo. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser
B) Síndrome de insensibilidad completa a los andrógenos (Morris)
C) Síndrome de Turner
D) Síndrome de Kallmann
E) Himen imperforado

Respuesta B. Mamas desarrolladas con ausencia total de vello axilar y púbico, más masas inguinales (testículos), definen el síndrome de Morris. En Rokitansky el vello es normal; en Turner hay talla baja y mamas poco desarrolladas; en Kallmann no hay desarrollo mamario ni vello, y hay anosmia; el himen imperforado da dolor cíclico con útero presente.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 19 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 22 años consulta por amenorrea de 4 meses de evolución, sin otras alteraciones. Se realiza exámenes, que muestran test de embarazo negativo, TSH y prolactina, que están dentro de rangos normales. Se solicita prueba de progesterona, que resulta negativa y prueba de estrógeno y progesterona, que resulta positiva. Además, se solicita LH y FSH, que están normales, dentro del límite bajo. El diagnóstico más probable es:

A) Prolactinoma
B) Falla ovárica primaria
C) Embarazo ectópico
D) Amenorrea hipotalámica
E) Síndrome de ovario poliquístico

Respuesta D. Tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico (las gonadotropinas normales se consideran como hipogonadotrófico), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria (el hipo- hipo es hipo-hipo).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 153 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 16 años, sin antecedentes, es traída por no presentar aún menarquia, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se aprecia talla de 1.53 metros y desarrollo puberal tanner 1, sin otros hallazgos. Se realiza test de progesterona que resulta negativo. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Anovulación
B) Malformación uterina
C) Hipopituitarismo
D) Hipotiroidismo
E) Síndrome de turner

Respuesta E. Tiene retraso puberal, talla de 1,53 metros (no es talla baja propiamente tal, pero es una talla que no descarta Turner) y probablemente un hipogonadismo. No tiene clínica de hipopituitarismo (hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal), sino solo del hipogonadismo. Todo hipogonadismo en una niña es un Turner, hasta que se demuestre lo contrario, en particular si es baja.

1.03.1.011 Síndrome climatérico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 20.12 Climaterio, Menopausia y Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH): Ventana de Oportunidad y Riesgos

QUÉ HAY QUE SABER

- Menopausia: diagnóstico clínico tras 12 meses sin regla en mujer >45 años; no pedir FSH de rutina (solo si se sospecha falla ovárica antes de los 40).
- Síntomas: a corto plazo bochornos, sudoración nocturna, insomnio y labilidad; a mediano plazo síndrome genitourinario (sequedad, dispareunia, disuria); a largo plazo osteoporosis y riesgo cardiovascular.
- Terapia hormonal si los síntomas afectan la calidad de vida, dentro de la ventana de oportunidad (<60 años o <10 años de menopausia): con útero, estrógeno + progestágeno obligatorio; histerectomizada, estrógeno solo. Dosis mínima eficaz, preferir vía transdérmica si hay riesgo trombótico.

- Contraindicaciones absolutas: cáncer de mama o endometrio, trombosis o evento cardiovascular, sangrado uterino no estudiado, hepatopatía activa. Alternativas no hormonales: venlafaxina, ISRS (no paroxetina con tamoxifeno) o gabapentina; estrógeno vaginal tópico para la atrofia.
- Seguimiento completo: control anual con mamografía, PA, perfil lipídico y glicemia, densitometría según riesgo, y reevaluar periódicamente la necesidad de continuar la terapia; medidas generales (ejercicio, calcio, vitamina D, dejar el tabaco).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 53 años, con menopausia hace 2 años, consulta por bochornos intensos, unos 10 al día, que alteran su sueño y su trabajo. Tiene antecedente de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, operado hace 4 años, en tratamiento con anastrozol. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para sus bochornos?**

A) Estradiol transdérmico más progesterona micronizada
B) Venlafaxina
C) Tibolona
D) Estrógenos conjugados orales solos
E) Esperar, porque los bochornos ceden solos en 6 meses

Respuesta B. El cáncer de mama hormonodependiente contraindica toda terapia hormonal, incluida la tibolona, que aumenta la recurrencia. Para bochornos moderados a severos se usan alternativas no hormonales: venlafaxina, ISRS (evitando paroxetina si usa tamoxifeno) o gabapentina, junto a medidas generales.

1.03.1.012 Hipogonadismo masculino

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 7.23 Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospecha clínica: disminución de libido, disfunción eréctil, menos vello corporal y facial, testículos pequeños, ginecomastia, infertilidad, pérdida de masa muscular y osteoporosis.
- Confirmación con testosterona total matinal (repetida); luego LH y FSH para clasificar: altas = hipogonadismo primario o hipergonadotropo (Klinefelter 47,XXY con testículos pequeños y firmes, orquitis, quimioterapia o radioterapia); bajas o normales = central.
- Central: medir prolactina y pedir RM de silla turca (prolactinoma, macroadenoma, sobre todo si hay hemianopsia); Kallmann con anosmia; también obesidad, opioides, anabólicos y enfermedad crónica.
- Inicial: tratar causas reversibles (suspender anabólicos u opioides, bajar de peso, cabergolina si hay prolactinoma) y derivar a endocrinología para confirmar y definir terapia con testosterona (contraindicada con cáncer de próstata o mama, hematocrito alto o deseo de fertilidad).
- Seguimiento por el médico general durante el reemplazo: síntomas, testosterona, hematocrito (poliglobulia), PSA y tacto rectal en mayores de 40–50 años, y densitometría.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 171

Un paciente de 32 años consulta por disfunción sexual asociada a disminución del vello facial. Al examen físico presenta disminución del vello corporal y disminución bilateral del tamaño testicular. **¿Cuál es el estudio más adecuado para proseguir el enfrentamiento de este paciente?**

A) Prolactina
B) Testosterona y LH
C) Espermiograma y FSH
D) Ecografía testicular
E) HCG y estradiol

Respuesta B. Disfunción sexual, menos vello y testículos pequeños son hipogonadismo clínico. Se confirma con testosterona total matinal y se mide LH para clasificarlo: LH alta indica falla testicular primaria (ej. Klinefelter); LH baja o normal indica causa hipotálamo-hipofisaria, que obliga a medir prolactina y a estudiar la silla turca.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Hombre de 38 años con disminución de la libido, disfunción eréctil, fatiga y ginecomastia bilateral. Testículos de tamaño normal. ¿Cuál es el estudio de elección inicial?

A) Testosterona total sérica matinal
B) Ecografía testicular
C) Espermograma
D) FSH y LH
E) Prolactina

Respuesta A. Hipogonadismo masculino: el estudio inicial es testosterona total sérica en la mañana (máxima entre 8-10 AM). Si está baja, se complementa con LH/FSH para clasificar en primario o secundario.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años, padre de tres hijos consulta por disfunción eréctil progre- siva que inició hace 3 meses. Su examen físico no muestra alteraciones, y su examen ge- nital y testicular resulta normal. Se solicitan exámenes que muestran testosterona de 190 ng/dL (valor normal: 280-1100ng/dL) y LH de 1,8 UI/L (valor normal: 1,5-20 UI/L). ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente?

A) Espermiograma
B) Ecografía testicular
C) Niveles plasmáticos de FSH
D) Resonancia magnética de hipófisis
E) Niveles plasmáticos de estrógeno y progesterona

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Resonancia magnética de hipófisis). Tiene un hipogonadismo hipogonadotrópico, por tanto probablemente es hipota- lámico o hipofisiario.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 50 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años, desde hace un año, presenta debilidad muscular, disminución de la libido e impotencia sexual progresiva. Se realizan exámenes, que muestran prolactina normal, niveles de LH: 1,6 UI/L (valor normal: 1,8 a 8,6 UI/L) y de testosterona: 160 ng/dl (valor normal: 270 a 1.070 ng/dl). ¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?

A) Ecografía testicular
B) Niveles plasmáticos de estradiol
C) Niveles de FSH
D) Solicitar niveles de testosterona libre
E) Resonancia magnética de hipófisis

Respuesta E. Tiene un hipogonadismo (testosterona baja) hipogonadotrópico (LH baja), por lo que es de causa hipotalámica o hipofisiaria ("el hipo hipo es hipo hipo"). Se estudia con RMN de hipófisis. Vale la pena mencionar que, si la LH hubiese estado normal, en la zona "baja" del rango normal, igualmente sería un hipogonadismo hipogonadotrópico.

1.03.1.013 Tumores hipofisiarios

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.20 Masas Selares, Adenomas Hipofisiarios y Apoplejía Hipofisaria · Tema 7.21 Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica · Tema 7.22 Acromegalia y Gigantismo: Diagnóstico Bioquímico y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Adenomas hipofisarios: prolactinoma 40 %, no funcionante 30–35 %, somatotropo 15 %, corticotropo 10 %; microadenoma <10 mm, macroadenoma ≥10 mm. Diferencial: craneofaringioma (niños y >50 años, quístico calcificado), meningioma, quiste de Rathke.
- Sospecha: cefalea, hemianopsia bitemporal por compresión del quiasma, oftalmoplejía por invasión del seno cavernoso, síntomas de hipersecreción (amenorrea-galactorrea, acromegalia, Cushing) o de hipopituitarismo.
- Estudio triple: RM de silla turca con gadolinio, campimetría computarizada y perfil hormonal completo (prolactina, IGF-1, cortisol y ACTH, TSH y T4 libre, FSH/LH y esteroides sexuales).
- Inicial: prolactinoma, cabergolina aunque haya hemianopsia; reemplazar déficits (hidrocortisona antes que levotiroxina). Apoplejía hipofisaria (cefalea en trueno, pérdida visual, III par, hipotensión): hidrocortisona 100 mg EV inmediata y RM urgente.
- Derivar a endocrinología y neurocirugía: cirugía transesfenoidal en macroadenoma no funcionante compresivo, acromegalia y Cushing; incidentaloma no funcionante <10 mm asintomático, RM a los 12 meses.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 138

Una paciente cefalea de 4 semanas de evolución, mayor en las mañanas, que se asocia a vómitos y, además, refiere alteraciones visuales. Al examen físico tiene fuerzas y sensibilidad conservada en las 4 extremidades y en el campo visual se constata hemianopsia bitemporal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Tumor de la glándula pineal
B) Glioma del nervio óptico
C) Tumor de la base del lóbulo frontal
D) Hiperprolactinemia
E) Macroadenoma hipofisiario

Respuesta E. Cefalea con vómitos y hemianopsia bitemporal: masa que comprime el quiasma desde abajo. El diagnóstico es un macroadenoma hipofisario.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 111

Un paciente consulta por disminución del deseo sexual y de las erecciones. Además, presenta astenia y debilidad, que ha ido aumentando, desde hace algunos meses. También, refiere haber chocado con un mueble, por no haberlo visto, resultado con lesiones. Al examen físico se aprecia pálido, con disminución del vello corporal, tiene edema de extremidades inferiores y disminución de la visión en la zona temporal del campo visual. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de este paciente?**

A) Radiografía de silla turca
B) Prolactinemia
C) Resonancia magnética de silla turca
D) Fondo de ojo
E) TAC de cerebro

Respuesta C. Compresión del quiasma (choca con un mueble, pérdida del campo temporal) más hipopituitarismo (libido, astenia, pérdida de vello): tumor hipofisario. El examen de elección es la RM de silla turca.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 24

Una paciente de 32 años, consulta por un cuadro de 6 meses de amenorrea, asociado a secreción mamaria bilateral. No utiliza método anticonceptivo y es sexualmente activa. Además, ha presentado cefalea que ha aumentado en las últimas semanas, de predominio matinal. Al examen mamario se objetiva escasa galactorrea y al examen neurológico se constata presencia de una hemianopsia bitemporal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Craneofaringioma
B) Macroadenoma hipofisiario
C) Glioma cerebral
D) Apoplejía hipofisiaria
E) Accidente vascular encefálico

Respuesta B. Amenorrea-galactorrea (hiperprolactinemia) más hemianopsia bitemporal (compresión del quiasma): macroadenoma hipofisario. La apoplejía sería un cuadro agudo con cefalea en trueno.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 123

Paciente con astenia, disminución de la libido, disfunción eréctil progresiva y alteración visual en zonas temporales. **¿Cuál es el examen de elección?**

A) RNM de silla turca
B) Campo visual computarizado
C) TAC de cerebro con contraste
D) Testosterona total sérica y FSH/LH
E) Ecografía testicular bilateral

Respuesta A. Hipogonadismo en un varón con defecto del campo visual temporal: masa selar que comprime el quiasma, típicamente un macroadenoma. El examen de elección es la resonancia de silla turca.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 113

Un paciente presenta astenia y aumento de tamaño de la mandíbula, con separación entre los dientes. Además refiere hipertrofia malar, de la nariz y las manos. También ha aumentado el número de sus zapatos. **¿Qué examen es más adecuado para continuar el estudio de este paciente?**

A) Niveles de hormona de crecimiento
B) Radiografías de pies y de la arcada dentaria
C) Radiografía de manos
D) Niveles de IGF-1
E) Resonancia magnética de hipófisis

Respuesta D. La acromegalia se estudia primero con somatomedina C o IGF-1 (son sinónimos). La GH es muy errática y no se pide.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 32

Un paciente de 30 años presenta astenia, malestar general y sudoración nocturna desde hace dos meses. Al examen físico registra frecuencia cardíaca: 89 lpm, presión arterial: 130/90 mmHg, se observa prognatismo y dedos de las manos gruesos. **¿Cuál de las siguientes hormonas estará elevada con mayor probabilidad?**

A) Tiroxina
B) Factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1)
C) FSH
D) Tirotropina (TSH)
E) ACTH

Respuesta B. La sospecha es una acromegalia, producida por un tumor hipofisario productor de GH. El examen de elección es la IGF-1, que estará elevada.

Pregunta de práctica

Hombre de 46 años con 5 años de cambio progresivo de rasgos faciales, separación dental con maloclusión y aumento de talla de zapatos de 41 a 44. Su cónyuge relata ronquidos con pausas respiratorias. Examen: macroglosia, nariz ancha, prognatismo, manos grandes, PA 160/95 mmHg. Glicemia de ayuno 142 mg/dL. Se sospecha acromegalia. **¿Cuál es el primer examen que debe solicitarse?**

A) Hormona de crecimiento basal matinal
B) IGF-1 sérica
C) Resonancia magnética de silla turca con gadolinio
D) Prolactina plasmática
E) Radiografía de manos y pies

Respuesta B. Clínica clásica de acromegalia. El tamizaje de primera línea es la IGF-1, que integra la secreción de GH de las últimas semanas. La GH basal es pulsátil y no sirve. La RM se pide después de confirmar con PTGO. Luego: cirugía transesfenoidal, colonoscopía y ecocardiograma.

1.03.1.014 Hipopituitarismo

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.23 Hipopituitarismo, Síndrome de Sheehan y Panhipopituitarismo

QUÉ HAY QUE SABER

- Hipopituitarismo: déficit de una o más hormonas hipofisarias por macroadenoma, cirugía o radioterapia selar, apoplejía o síndrome de Sheehan (necrosis hipofisaria tras hemorragia obstétrica con shock).
- Sheehan: agalactia (síntoma más precoz), amenorrea, pérdida de vello axilar y pubiano, hipotiroidismo (astenia, frío, piel seca) y déficit corticotropo (hipotensión, hiponatremia, hipoglicemia).
- Sello bioquímico: hormona periférica baja con tropina baja o inapropiadamente normal (cortisol bajo con ACTH no elevada; T4 libre baja con TSH normal o baja; estradiol o testosterona bajos con FSH/LH no elevadas); RM de silla turca (adenoma o silla turca vacía).
- Regla de oro: hidrocortisona 15–20 mg/día primero y levotiroxina 24–48 h después (la levotiroxina sola puede precipitar una crisis suprarrenal); luego esteroides sexuales según edad y deseo de fertilidad. En crisis, hidrocortisona 100 mg EV.
- Derivar a endocrinología. Controlar la levotiroxina con T4 libre (no con TSH) y la hidrocortisona por clínica; educar en dosis de estrés.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 109

Una paciente de 28 años, se realiza una histerectomía postparto, por una inercia uterina. Usted la atiende 6 meses después, sin lactancia y permaneciendo en amenorrea. Presenta un cuadro de astenia, adinamia y malestar general, asociada a debilidad. Tiene piel seca, con cabello quebradizo, palidez y su presión arterial es de 90/60 mmHg. **El diagnóstico más probable es:**

A) Tiroiditis postparto
B) Panhipopituitarismo
C) Depresión postparto
D) Insuficiencia ovárica
E) Hipotiroidismo

Respuesta B. Hemorragia obstétrica seguida de agalactia, astenia, piel seca e hipotensión: síndrome de Sheehan, con falla de varios ejes hipofisarios (tiroideo, suprarrenal, lactotropo). El hipotiroidismo que tiene es central; por eso se descarta la insuficiencia suprarrenal antes de dar levotiroxina.

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años, con cefaleas esporádicas previas, consulta por 3 horas de cefalea holocraneana súbita "en estallido", vómitos, ptosis derecha, diplopía y somnolencia. PA 85/50 mmHg. Parálisis completa del III par derecho con midriasis y defecto campimétrico bitemporal severo. TC: masa selar con focos de hemorragia aguda. **¿Cuál es la medida inicial de máxima prioridad?**

A) Manitol al 20 % en infusión rápida
B) Hidrocortisona 100 mg EV en bolo
C) Cabergolina por sonda nasogástrica
D) Heparina de bajo peso molecular subcutánea
E) Somatostatina EV continua

Respuesta B. Apoplejía hipofisaria: la hemorragia destruye la hipófisis, cae la ACTH y aparece una insuficiencia suprarrenal aguda secundaria (hipotensión). La primera medida es hidrocortisona 100 mg EV inmediata; luego RM y descompresión transesfenoidal urgente por el compromiso visual.

Pregunta de práctica

Mujer de 36 años con astenia invalidante, intolerancia al frío y piel seca. Hace 2 años, parto complicado con hemorragia por atonía uterina, politransfusión e histerectomía. Nunca logró amamantar y no ha vuelto a menstruar. Pálida, cérea, PA 90/60 mmHg, sin vello axilar ni pubiano. T4L 0,4 ng/dL, TSH 1,1 mUI/L, cortisol 1,9 mcg/dL, ACTH 6 pg/mL, FSH 1,8 UI/L. **¿Cuál es la conducta terapéutica inicial más adecuada?**

A) Levotiroxina 100 mcg/día y controlar TSH en 6 semanas
B) Hidrocortisona oral y, 24–48 horas después, levotiroxina
C) Estrógenos y progestágenos para recuperar las menstruaciones
D) Levotiroxina e hidrocortisona el mismo día, luego ajustar según TSH
E) Cabergolina para recuperar la lactancia

Respuesta B. Síndrome de Sheehan: hemorragia posparto, agalactia, amenorrea y pérdida de vello, con hormonas periféricas bajas y tropinas bajas o inapropiadamente normales. Se inicia hidrocortisona y, 24–48 h después, levotiroxina, titulada con T4 libre. Partir con levotiroxina puede precipitar una crisis suprarrenal.

1.03.1.015 Diabetes insípida

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.24 Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) · Tema 2.3 Hipernatremia y Diabetes Insípida (Central vs Nefrogénica)

QUÉ HAY QUE SABER

- Diabetes insípida: poliuria hipotónica >3–5 L/día con polidipsia y nicturia, osmolalidad urinaria <300 y densidad <1.005; sodio normal si accede al agua, hipernatremia si no.
- Central (falta de ADH): TEC, neurocirugía o cirugía selar, histiocitosis, sarcoidosis. Nefrogénica (resistencia renal): litio (causa n.º 1), hipercalcemia, hipokalemia.
- Diferencial con polidipsia primaria (psicógena), que no sube el sodio; descartar también diabetes mellitus (glucosuria).
- Confirmación: test de restricción hídrica seguido de desmopresina (2–4 mcg SC o 20 mcg nasal): si la osmolalidad urinaria sube más de 50 % es central; si sube menos, nefrogénica. Con hipernatremia ya presente, no restringir agua: directo a desmopresina.

- Inicial: asegurar acceso a agua y corregir la hipernatremia lentamente; desmopresina nasal u oral en la central; en la nefrogénica retirar la causa e hidroclorotiazida + amilorida. Seguimiento: derivar a endocrinología o nefrología.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 124

Niño operado de cirugía cerebral, luego presenta hipernatremia y poliuria. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de secreción inadecuada de ADH (SIADH)
B) Diabetes mellitus tipo 1
C) Hiperaldosteronismo secundario
D) Diabetes insípida central
E) Polidipsia psicogénica

Respuesta D. Poliuria con hipernatremia tras una neurocirugía: falta de ADH por daño hipotalámico o del tallo. El SIADH, por exceso de ADH, retiene agua y causa hiponatremia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 105

Una paciente de 16 años de edad, con cuadro caracterizado por polidipsia y poliuria desde hace aproximadamente 3 semanas, no asociado a otros síntomas. Se realizan exámenes donde destaca osmolaridad plasmática disminuida, por lo que se solicita test de la sed que muestra normalización de diuresis y osmolaridad plasmática. **El diagnóstico más probable es:**

A) Polidipsia psicógena
B) Diabetes insípida nefrogénica
C) Diabetes insípida central
D) Hipercalcemia
E) Diabetes mellitus tipo 1

Respuesta A. Poliuria y polidipsia con osmolaridad plasmática baja: el exceso es de agua ingerida. Al restringir el agua (test de la sed), la diuresis y la osmolaridad se normalizan porque el riñón y la ADH funcionan: polidipsia psicógena. En la diabetes insípida la osmolaridad plasmática tiende a estar alta y la poliuria persiste con la privación.

Pregunta de práctica

Hombre de 22 años con TEC cerrado y fractura de base de cráneo. Al tercer día en UCI presenta poliuria de 600 mL/hora durante 4 horas. Na 150 mEq/L, Osm urinaria 140 mOsm/kg. Se sospecha diabetes insípida central. **¿Cuál es la prueba diagnóstica y terapéutica inicial de elección?**

A) Prueba de privación de agua por 12 horas
B) Dosis de prueba de desmopresina y Osm urinaria seriada
C) Resonancia magnética de silla turca con gadolinio
D) Vasopresina plasmática tras suero hipertónico
E) Hidroclorotiazida más amilorida

Respuesta B. Poliuria hipotónica con hipernatremia tras un trauma de base de cráneo: sospecha de DI central. Con hipernatremia establecida, la privación de agua está contraindicada. La dosis de prueba de desmopresina confirma el diagnóstico si la Osm urinaria sube más de 50% y el volumen urinario cae, y a la vez trata. Tiazida + amilorida es para la DI nefrogénica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 80 · texto original del banco, sin revisar

Hombre con poliuria, polidipsia y nicturia. Toma 8 lts de agua al dia. En los exámenes destaca hiponatremia, como inicia el estudi n o?:

A) Ecografía renal
B) Electrolitos urinarios (no puede ser esta? Dice estudio inicial, se necesita la osm urinaria y luego deprivar y comparar o no??? -> Pero estudio de deprivación incluye la medición de OsmU y NaU pre y post deprivación), es esta, salía en ensayos anteriores
C) TAC de no se q
D) Test de deprivación de agua (esto es para hipernatremia sg yo)
E) Derivar a psiquiatría f. PTGO

Respuesta B. La alternativa correcta es la B (Electrolitos urinarios (no puede ser esta? Dice estudio inicial, se necesita la osm urinaria y luego deprivar y comparar o no??? -> Pero estudio de deprivación incluye la medición de OsmU y NaU pre y post deprivación), es esta, salía en ensayos anteriores). El SIADH se produce por exceso de hormona antidiurética, que retiene agua y causa hiponatremia. Esta decisión

1.03.1.016 Hiperprolactinemia

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.21 Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica · Tema 20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- La prolactina vive frenada por la dopamina: sube con prolactinoma, fármacos anti-D2, compresión del tallo, hipotiroidismo primario, insuficiencia renal o cirrosis, y causas fisiológicas (embarazo, lactancia, estrés, estimulación del pezón).
- Clínica: en la mujer amenorrea u oligomenorrea, infertilidad y galactorrea; en el hombre debut tardío con baja libido, disfunción eréctil y ginecomastia, a menudo con macroadenoma (cefalea, hemianopsia bitemporal).
- Estudio: beta-hCG primero; prolactina en ayunas y reposo (>25 ng/mL); revisar fármacos (risperidona, haloperidol, metoclopramida, domperidona, ISRS) y medir TSH y creatinina. 25–100 sugiere fármacos, hipotiroidismo o microadenoma; >200–250, macroprolactinoma casi seguro.
- Descartadas causas secundarias y si persiste: RM de silla turca con gadolinio y campimetría si es macroadenoma. Hipotiroidismo: tratar con levotiroxina; fármaco: cambiarlo si es posible.
- Prolactinoma de cualquier tamaño: cabergolina 0,5 mg 1–2 veces por semana (normaliza la prolactina en 85–90 % y reduce el tumor); cirugía solo si hay resistencia o intolerancia. Derivar a endocrinología; control de prolactina a los 3 meses y RM al año.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 131

Una paciente de 25 años, sin antecedentes de importancia, consulta por mastalgia bilateral de 5 días de evolución. Al examen físico, se observa galactorrea bilateral al comprimir los pezones. Su FUR fue hace 12 días y no toma medicamentos. ¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio? **¿Cuál es el examen más adecuado para iniciar el estudio?**

A) Subunidad beta de gonadotropina coriónica humana en plasma
B) Prolactinemia
C) Resonancia magnética de silla turca
D) Ecotomografía mamaria
E) Mamografía

Respuesta A. Ante galactorrea, lo primero es descartar embarazo, aunque la FUR sea reciente. Luego se busca hiperprolactinemia, cuya causa principal son los fármacos y después los adenomas hipofisarios.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 79

Una paciente de 26 años, sin antecedentes mórbidos, consulta por historia de tres meses de amenorrea asociada a galactorrea, sin otros síntomas, con prueba de detección de bHCG en orina negativa en dos oportunidades. Su examen físico resulta normal, su índice de masa corporal es de 20. **El examen de elección para iniciar el estudio en este caso es:**

A) Hormona estimulante tiroidea
B) Prueba de progesterona
C) Ecografía transvaginal
D) Prolactina
E) Prueba de estrógeno más progesterona

Respuesta D. Síndrome de amenorrea-galactorrea con embarazo descartado: es una hiperprolactinemia hasta demostrar lo contrario, y se inicia el estudio con prolactina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 111

Una paciente de 38 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados desde hace 4 meses, consulta por galactorrea de algunas semanas de evolución, sin otros síntomas. Las mamas se palpan sin nódulos y se objetiva la galactorrea al comprimirlas. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solicitar niveles de progesterona
B) Solicitar niveles de prolactina
C) Cambiar los anticonceptivos a progestágenos solos
D) Solicitar TAC de cerebro
E) Solicitar niveles plasmáticos de estradiol, LH y FSH

Respuesta B. Toda galactorrea fuera del embarazo y la lactancia se estudia primero con prolactina plasmática (junto a TSH y descartar fármacos). Los anticonceptivos enmascaran la amenorrea que acompañaría a una hiperprolactinemia. La imagen, que es la resonancia de silla turca y no la TAC, se pide solo con prolactina elevada sin causa secundaria.

Pregunta de práctica

Mujer de 26 años, nulípara, con amenorrea secundaria de 8 meses y galactorrea bilateral espontánea desde hace 4 meses. No usa fármacos. Campo visual normal. Beta-hCG negativa, TSH 1,8 mUI/L. Prolactina en reposo 165 ng/mL (VN < 25). RM de silla turca: lesión intraselar de 7 mm compatible con microadenoma. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Cirugía transesfenoidal
B) Cabergolina oral
C) Anticonceptivos orales combinados
D) Levotiroxina
E) Radiocirugía estereotáxica

Respuesta B. Microprolactinoma con amenorrea-galactorrea, con embarazo, hipotiroidismo y fármacos descartados. El tratamiento de primera línea de todo prolactinoma es médico con cabergolina: normaliza la prolactina, restablece ciclos ovulatorios y fertilidad, y reduce el tumor en más del 80 %.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 72 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años, usuaria de T de cobre desde hace 5 años, consulta porque, desde hace 8 meses está en amenorrea. Al examen físico tiene galactorrea bilateral a la compresión del pezón, sin otras alteraciones en el examen ginecobstétrico ni en el examen físico general. ¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio?

A) Niveles plasmáticos de HCG
B) Resonancia magnética de silla turca
C) Niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH, FSH y TSH
D) Ecografía transvaginal
E) Prolactinemia

Respuesta C. La alternativa correcta es la C (Niveles plasmáticos de estradiol, progesterona, LH, FSH y TSH). 1. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Niveles plasmáticos de HCG, Resonancia magnética de silla turca) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuer

1.03.1.017 Síndrome de secreción inapropiada de ADH

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 7.24 Diabetes Insípida, SIADH y Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN)

QUÉ HAY QUE SABER

- SIADH: hiponatremia hipotónica euvolémica por ADH autónoma; el sodio urinario alto se debe a la natriuresis por péptidos natriuréticos.
- Criterios: Na <135 y osmolalidad plasmática <275; osmolalidad urinaria >100 (inapropiadamente concentrada); Na urinario >30–40; euvolemia clínica, con TSH, cortisol y función renal normales y sin diuréticos.
- Causas: cáncer pulmonar de células pequeñas (>70 % de los ectópicos), patología pulmonar (neumonía, TBC) y del SNC (meningitis, TEC, ACV), fármacos (ISRS, carbamazepina, ciclofosfamida), dolor y náuseas postoperatorias.
- Tratamiento: restricción hídrica a 500–1.000 mL/día y tratar la causa; el suero fisiológico puede empeorar la hiponatremia. Con convulsiones o coma, suero salino hipertónico al 3 % en infusión controlada.
- Corregir como máximo 8–10 mEq/L en 24 h por riesgo de mielinólisis pontina. Seguimiento: control de natremia y búsqueda de la causa (radiografía de tórax, revisar fármacos); si es crónico, tolvaptán o urea por especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 62 años con carcinoma pulmonar de células pequeñas en tratamiento, traído por astenia, náuseas, marcha inestable y confusión progresiva. Sin edema, mucosas húmedas, yugulares normales, PA 130/80 mmHg. Na 118 mEq/L, K 4,0 mEq/L, Osm plasmática 245 mOsm/kg, Osm urinaria 480 mOsm/kg, Na urinario 54 mEq/L. Función renal, TSH y cortisol normales. No ha convulsionado. **¿Cuál es la base del tratamiento?**

A) Suero fisiológico 0,9 % a chorro
B) Restricción hídrica a 500–1000 mL/día
C) Desmopresina intranasal
D) Furosemida y albúmina
E) Corregir el sodio a 135 mEq/L en las primeras 24 horas

Respuesta B. SIADH paraneoplásico por oat cell: hiponatremia hipotónica euvolémica, Osm urinaria sobre 100, Na urinario sobre 30, con renal, tiroides y suprarrenal normales. La base es la restricción hídrica. Si convulsiona o entra en coma, salino al 3 % sin superar 8–10 mEq/L en 24 h, para evitar la mielinólisis pontina.

1.03.1.018 Osteoporosis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento · Tema 9.24 Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico: DEXA de columna y cadera; T-score ≤ –2,5 en cualquier sitio = osteoporosis, entre –1 y –2,5 osteopenia; la fractura por fragilidad (cadera, vértebra, húmero proximal, Colles tras caída de propia altura) es diagnóstica aunque el T-score no llegue a –2,5.
- Tamizaje con DEXA en mujeres ≥65 años o posmenopáusicas con factores de riesgo (corticoides, fractura previa, IMC <20, tabaco, alcohol, padre o madre con fractura de cadera). Laboratorio básico (calcio, fósforo, fosfatasas, función renal, 25(OH)D, TSH) para descartar causas secundarias.
- Tratar con fármacos si hay fractura por fragilidad, T-score ≤ –2,5, corticoides crónicos (prednisona ≥5–7,5 mg/día >3 meses) u osteopenia con FRAX ≥20 % fractura mayor o ≥3 % cadera.
- Alendronato 70 mg semanal (o risedronato) en ayunas con un vaso de agua de la llave, erguido 30–60 min sin comer; zoledrónico 5 mg EV anual si hay reflujo o mala adherencia. Siempre calcio 1.000–1.200 mg/día y vitamina D 800–2.000 UI/día; denosumab o teriparatida en casos seleccionados.
- Seguimiento: DEXA cada 1–2 años, prevención de caídas y vacaciones terapéuticas del bifosfonato a los 3–5 años (riesgo de osteonecrosis mandibular y fractura atípica de fémur).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 114

Una paciente de 65 años, en tratamiento con calcio 2 gramos al día y vitamina D, 600 UI al día, se realiza una densitometría ósea que muestra un T score de -2,7 en la cadera derecha y de -2,8 en la columna lumbar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar ejercicio aeróbico
B) Indicar reposo relativo
C) Aumentar dosis de vitamina D y calcio
D) Agregar bifosfonatos al tratamiento
E) Mantener el tratamiento

Respuesta D. T-score ≤ -2,5: osteoporosis. Calcio y vitamina D son la base, pero no bastan: se agrega el bifosfonato y se mantienen los suplementos.

Pregunta de práctica

Mujer de 67 años, menopáusica desde los 50 sin terapia hormonal, sin fracturas previas. DEXA: T-score -2,8 en columna lumbar y -2,6 en cuello femoral. Calcemia, fosfemia, fosfatasas alcalinas, función renal y hemograma normales. Sin reflujo ni pirosis. Se inicia alendronato 70 mg semanal. **¿Qué indicación de administración es correcta?**

A) Tomarlo en la noche, antes de acostarse, con un vaso de leche
B) Tomarlo con el desayuno para evitar la irritación gástrica
C) Tomarlo en ayunas con un vaso lleno de agua de la llave y mantenerse erguida 30 a 60 minutos
D) Tomarlo junto con el comprimido de calcio para que se absorban juntos
E) Disolverlo en jugo de naranja para mejorar su absorción

Respuesta C. Osteoporosis densitométrica (T-score ≤ -2,5): bifosfonato con calcio y vitamina D. El alendronato se absorbe menos del 1 %: en ayunas, solo con agua de la llave, erguida 30–60 minutos y sin comida ni otros fármacos, para asegurar la absorción y evitar la esofagitis.

Pregunta de práctica

Mujer de 76 años previamente autovalente resbala en el pasillo de su casa y cae desde su propia altura, sufriendo dolor intenso en la ingle derecha e incapacidad funcional para la bipedestación. La radiografía de pelvis confirma una fractura subcapital desplazada del cuello femoral derecho, por lo que es hospitalizada para artroplastía de cadera. No cuenta con densitometría ósea previa. ¿Cuál es el diagnóstico esquelético que se establece clínicamente de manera automática y cuál es la conducta farmacológica apropiada para el alta?

A) Osteopenia leve; indicar suplemento de vitamina D3 aislada y solicitar densitometría ósea ambulatoria antes de cualquier fármaco
B) Osteoporosis clínica establecida; iniciar tratamiento con calcio, vitamina D y terapia antirresortiva (bifosfonato o denosumab) sin requerir densitometría previa
C) Trauma mecánico aislado sin osteoporosis; no requiere tratamiento farmacológico óseo ya que la fractura es traumática
D) Osteomalacia por déficit de calcio; indicar calcitriol a altas dosis y diferir los antirresortivos de forma definitiva
E) Artrosis de cadera complicada; iniciar condroitín sulfato y AINEs de forma indefinida

Respuesta B. Toda fractura producida por un traumatismo de bajo impacto (caída desde la propia altura) en sitios cardinales como cadera o columna vertebral en un adulto mayor establece por sí misma el diagnóstico clínico de Osteoporosis (incluso Osteoporosis Severa/Establecida). No es necesario realizar ni esperar una densitometría ósea previa para justificar el inicio de terapia antirresortiva farmacológica (bifosfonato como alendronato o ácido zoledrónico, o denosumab) asociada a suplementación de calcio y vitamina D.

1.03.1.019 Osteoporosis secundaria

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar osteoporosis secundaria en hombres jóvenes, mujeres premenopáusicas, Z-score ≤ –2,0, fracturas con mínimo trauma a edad temprana o pérdida ósea desproporcionada.
- En premenopáusicas y hombres menores de 50 años se usa el Z-score (compara con la misma edad): ≤ –2,0 = densidad baja para la edad y obliga a buscar causa.
- Causas: corticoides (la más frecuente), hipogonadismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing, déficit de vitamina D u osteomalacia, malabsorción (celiaquía), alcoholismo, mieloma, artritis reumatoide.
- Estudio inicial: calcio, fósforo, PTH, 25(OH)D, TSH, testosterona, función renal y hepática, hemograma, electroforesis de proteínas; según clínica antitransglutaminasa y cortisol libre urinario.
- Inicial: calcio y vitamina D, suspender o reducir corticoides si es posible y no dar bifosfonato antes de corregir el déficit de vitamina D. Seguimiento: derivar para tratar la causa y definir el antirresortivo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 45 años presenta una fractura vertebral por aplastamiento tras un esfuerzo mínimo. La densitometría muestra un Z-score de –3,0 en columna. No tiene antecedentes conocidos ni usa fármacos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar bifosfonato sin otro estudio, porque es osteoporosis primaria
B) Repetir la densitometría en 2 años
C) Indicar solo calcio y vitamina D
D) Buscar causas secundarias: calcio, fósforo, PTH, vitamina D, TSH, testosterona, función renal y hepática, hemograma y electroforesis de proteínas
E) Iniciar terapia con estrógenos

Respuesta D. Osteoporosis en un hombre joven o con Z-score bajo –2 obliga a buscar causas secundarias: hipogonadismo, hiperparatiroidismo, hipertiroidismo, Cushing o corticoides, déficit de vitamina D, malabsorción (enfermedad celíaca), alcoholismo o mieloma, entre otras. Tratar la causa es parte central del manejo, junto al antirresortivo.

1.03.1.020 Hipercalcemias e hipocalcemias

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico · Tema 7.17 Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Siempre corregir por albúmina: calcio corregido = calcio + 0,8 × (4 – albúmina); en hipoalbuminemia puede ser una seudohipocalcemia (medir calcio iónico si hay duda).
- Hipercalcemia (>10,5 mg/dL): «huesos, cálculos, quejidos y gemidos» (dolor óseo, litiasis, poliuria, constipación, náuseas, letargia, QT corto). Primer examen: PTH; alta o inapropiadamente normal = hiperparatiroidismo primario (adenoma 85 %); suprimida = neoplasia (PTHrP, osteólisis), exceso de vitamina D o granulomas.
- Hipocalcemia: parestesias periorales, espasmo carpopedal, Chvostek y Trousseau, laringoespasmo, convulsiones y QT largo; causas: posquirúrgica (24–72 h post tiroidectomía), hipomagnesemia, déficit de vitamina D, pancreatitis, transfusión masiva.
- Inicial: hipercalcemia leve (<12), hidratación oral y suspender tiazidas y litio; ≥12 sintomática, hospitalizar con suero fisiológico EV. Hipocalcemia sintomática: gluconato de calcio 10 % EV y medir magnesio.
- Derivar a endocrinología: hiperparatiroidismo primario (paratiroidectomía si sintomático o cumple criterios), hipercalcemia PTH-independiente (buscar cáncer) e hipoparatiroidismo crónico (calcio oral + calcitriol, meta 8,0–8,5).

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 175

Un paciente de 32 años, con antecedente de litiasis renal a repetición se realiza exámenes, que muestran calcio plasmático: 9,8 mg/dl, albúmina: 3,0 g/dl, creatinina plasmática: 0,7 mg/dl, PTH: 90 UI/L (VN: 10 a 55 pg/ml) y calciuria de 200 mg/día (VN: 50 a 150 mg/día). **El diagnóstico más probable es:**

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hiperparatiroidismo secundario
C) Hiperparatiroidismo terciario
D) Hipercalciuria primaria
E) Hipercalciuria familiar

Respuesta A. Calcio corregido = 9,8 + 0,8 × (4 – 3) = 10,6 mg/dL: hay hipercalcemia. Con PTH elevada e hipercalciuria que explica la litiasis, es un hiperparatiroidismo primario. El secundario tiene calcio bajo o normal (típico de la IRC); en la hipercalciuria primaria la calcemia y la PTH son normales.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 167

Hombre de 55 años asintomático con calcio sérico 11.2 mg/dL, fósforo 2.1 mg/dL (bajo) y PTH 145 pg/mL (elevada). Sin otros hallazgos. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hiperparatiroidismo primario
B) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar
C) Hipercalcemia de malignidad
D) Intoxicación por vitamina D
E) Sarcoidosis

Respuesta A. Hipercalcemia + hipofosfatemia + PTH elevada en un paciente ambulatorio asintomático: hiperparatiroidismo primario, la causa más frecuente en este contexto. Malignidad, vitamina D y sarcoidosis tienen la PTH suprimida.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 121

Un paciente de 67 años consulta por dolores óseos en múltiples zonas. Se realiza exámenes, entre los que destaca calcemia corregida de 14,4 mg/dl, con pruebas de función renal normales. Además, se solicitan radiografías que muestran imágenes sugerentes de metástasis óseas. **¿Cuál es la conducta más adecuada para proseguir el estudio?**

A) Calciuria de 24 horas
B) Niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D
C) Niveles plasmáticos de paratohormona
D) Cintigrafía ósea
E) Niveles plasmáticos de calcio iónico

Respuesta C. Toda hipercalcemia se estudia con PTH: si está elevada es hiperparatiroidismo primario; si está suprimida, apoya el origen neoplásico. Las lesiones óseas también pueden deberse a hiperparatiroidismo (tumores pardos). La cintigrafía es inespecífica y aquí las lesiones ya se vieron.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 78

Paciente de 63 años, con antecedente de hipernefroma operado hace un año, con buena evolución, consulta por cuadro de astenia y debilidad de 7 días, controlándose exámenes de sangre entre los que destaca calcemia de 11,8 mg/dL (valor normal 8,5-10,5 mg/dL), albúmina normal. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de este paciente? **¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio?**

A) Cintigrafía ósea
B) Niveles plasmáticos de calcio y paratohormona
C) TAC de abdomen y pelvis
D) Niveles plasmáticos de vitamina D
E) Resonancia magnética de abdomen y pelvis

Respuesta B. Es una hipercalcemia, posiblemente paraneoplásica. Se estudia siempre con paratohormona: si está elevada, es hiperparatiroidismo primario; si está baja, es probablemente cáncer.

Pregunta de práctica

Mujer de 56 años con astenia, constipación de 3 meses, dolores óseos difusos y 2 cólicos renales en los últimos 2 años. Lúcida, hidratada, PA 135/85 mmHg. Calcio 11,6 mg/dL con albúmina 4,0 g/dL, fósforo 2,1 mg/dL, creatinina 0,9 mg/dL, PTH intacta 145 pg/mL (VN 15–65). Ecografía renal: microlitiasis bilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Ácido zoledrónico 4 mg EV
B) Control anual de calcio y densitometría
C) Localizar con cintigrama sestamibi y ecografía cervical, y paratiroidectomía
D) Furosemida oral y restricción de lácteos
E) Electroforesis de proteínas para descartar mieloma

Respuesta C. Hipercalcemia + hipofosfatemia + PTH elevada: hiperparatiroidismo primario. Es sintomática (litiasis recurrente), así que la cirugía es mandatoria: se localiza el adenoma con sestamibi y ecografía y se hace paratiroidectomía. La observación solo cabe en el asintomático sin criterios; con PTH elevada, el mieloma no explica el cuadro.

Pregunta de práctica

Hombre de 54 años, alcohólico crónico y desnutrido, ingresa con tetania y parestesias. Calcio sérico 6,8 mg/dL. Recibe dos bolos EV de gluconato de calcio al 10 %, pero persiste tetánico con calcio de 6,9 mg/dL. **¿Qué examen se debe solicitar de inmediato?**

A) Magnesemia
B) Calcitonina sérica
C) TSH
D) Ácido fólico plasmático
E) Plombemia

Respuesta A. Hipocalcemia refractaria a calcio EV en un alcohólico desnutrido: hipomagnesemia hasta demostrar lo contrario. Sin magnesio no se secreta PTH ni actúa en hueso y riñón. Se corrige con sulfato de magnesio EV y recién entonces responde el calcio.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 32 · texto original del banco, sin revisar

En el estudio de una osteoporosis de una paciente, se pesquisa tiene calcemia de 11 mg/dl, niveles de paratohormona de 155 UI/L (VN: 15 a 55), niveles de vitamina D: (VN:) y albúmina de 3,8 g/dl. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Hipercalcemia idiopática
B) Hiperparatiroidismo primario
C) Hiperparatiroidismo secundario
D) Hiperparatiroidismo terciario
E) Hipercalcemia familiar

Respuesta B. Diagnóstico: Hiperparatiroidismo primario (opción B). Calcio alto y PTH alta son característicos del HPP.. Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 8 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 58 años con calcio sérico de 11.8 mg/dL detectado en examen de rutina. Asintomática. Sin uso de suplementos de calcio ni vitamina D. ¿Cuál es el estudio inicial de elección para determinar la causa de la hipercalcemia?

A) PTH sérica
B) Fósforo sérico
C) Calcitonina
D) Calcio en orina de 24h
E) Vitamina D (25-OH)

Respuesta A. PTH es el primer examen a solicitar en hipercalcemia: PTH elevada = hiperparatiroidismo primario (causa más frecuente en ambulatorio). PTH suprimida = hipercalcemia de malignidad, intoxicación vitamina D u otras causas. Orienta todo el estudio.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 33 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente presenta su sexta litiasis urológica, por lo que se realizan exámenes, entre los que destacan creatinina: 1,2 mg/dl, BUN: 30 mg/dl, calcio: 11 mg/dl, fósforo: 2,3 mg/dl, natremia normal, potasemia normal. ¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir el estudio diagnóstico?

A) Paratohormona
B) LH y FSH
C) 25 OH vitamina D
D) Biopsia de médula ósea
E) Índice proteinuria / creatininuria

Respuesta A. Diagnóstico: Paratohormona (opción A). La hipercalcemia se estudia con PTH. Además, la hipofosfemia orienta a un HPP.. Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 89 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 35 años ha presentado 6 episodios, en el último año, de litiasis renal por cálculos cálcicos. ¿Qué alteración endocrinológica puede ser causante de esto?

A) Hipercortisolismo
B) Hipocortisolismo
C) Hiperprolactinemia
D) Hiperparatiroidismo
E) Hipoparatiroidismo

Respuesta D. El hiperparatiroidismo produce salida de calcio desde los huesos, lo que aumenta la calcemia y también la calciuria, produciendo litiasis urológica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 177 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 50 años, sin antecedentes, acude a realizarse un chequeo, asintomático. Su examen físico es normal. Trae exámenes que se habría tomado la semana pasada donde destaca hemoglobina 14 mg/dL, leucocitos 7.000/mm3, plaquetas 230.000/mm3, creatinina 0.8 mg/dL, calcio 11, albúmina 4, electrocardiograma normal. La conducta más adecuada en este caso es:

A) Mantener control ambulatorio anual
B) Solicitar cintigrafía ósea
C) Solicitar radiografía de huesos largos y huesos parietales
D) Solicitar niveles de paratohormona
E) Solicitar electroforesis de proteínas

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Solicitar niveles de paratohormona (opción D). Tiene el Calcio elevado (N menor a 10,5). Corregido por albúmina queda igual. Se debe pedir PTH.. Hiperparatiroidismo primario: tratamiento quirúrgico (tumorectomía o paratiroidectomía con implante) De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 172 · texto original del banco, sin revisar

¿Cual es el estudio de Hipercalcemia ? a. Calcemia y PTH 173. Había un AM con alteraciones de memoria creo, con VCM > 100: B12 (ALGUIEN RECUERDA ALGO DE ESTO)

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Hemograma y VHS). Clase sobre el tratamiento de la hipercalcemia e hipocalcemia. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES). Las opciones alternativas (Ecografía, Radiografía) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del

1.03.1.021 Nódulo tiroídeo

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.9 Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

QUÉ HAY QUE SABER

- Nódulos en 50–60 % de las mujeres por ecografía; solo 5–10 % son malignos (sobre todo papilar). Factores de riesgo: radiación cervical en la infancia, familiar con carcinoma medular o NEM 2, crecimiento rápido, disfonía, adenopatías duras.
- Primer paso: TSH. Si está suprimida, cintigrama: nódulo caliente (autónomo) casi nunca es maligno y no se punciona. Si es normal o alta, ecografía con TI-RADS (el cintigrama no aporta).
- Signos ecográficos de sospecha: sólido, marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, márgenes irregulares, microcalcificaciones. PAAF: TR3 desde 2,5 cm, TR4 desde 1,5 cm, TR5 desde 1 cm; TR1–TR2 nunca.
- Bethesda: I repetir PAAF; II benigno, control ecográfico en 12–24 meses; III repetir PAAF o test molecular; IV hemitiroidectomía diagnóstica; V y VI cirugía (tiroidectomía total o lobectomía).
- Derivar a especialista (GES cáncer de tiroides) con Bethesda IV–VI o adenopatías sospechosas. La levotiroxina supresora está en desuso.

PREGUNTAS (13)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 167

Un paciente de 30 años, presenta un nódulo tiroideo, que en el examen físico se palpa de consistencia elástica, indoloro, sin adenopatías cervicales. Se solicita TSH: 0,2 UI/L (VN: 0,3 a 5,0 UI/L), con T4 y T3 normales. Se solicita ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo sólido, redondo, de aspecto homogéneo, sin microcalcificaciones, de 3 cm de diámetro. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Realizar cintigrafía tiroidea
B) Realizar punción con aguja fina
C) Controlar con pruebas tiroideas en 6 meses
D) Solicitar niveles de tiroglobulina
E) Realizar cirugía

Respuesta A. La TSH está suprimida (hipertiroidismo subclínico con T4 y T3 normales). Con TSH baja, antes de puncionar se pide cintigrama: si el nódulo es caliente, es autónomo, casi nunca maligno y no requiere PAAF.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 65

Un paciente de 50 años consulta porque notó aumento de volumen en la zona anterior de su cuello. Al examen físico se palpa un nódulo de 2 cm de diámetro y consistencia dura. Se solicitan exámenes, entre los que destaca una TSH: 6,2 UI/L. **¿Cuál es el examen más adecuado para proseguir con el estudio?**

A) T4 libre
B) Ecografía cervical
C) Cintigrafía tiroidea
D) Estudio citológico por punción
E) Anticuerpos antitiroideos

Respuesta B. Con TSH normal o elevada, el siguiente paso ante un nódulo es la ecografía cervical con clasificación TI-RADS, que define si corresponde PAAF. El cintigrama solo se pide con TSH suprimida.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 38

Un paciente se realiza una ecografía de cuello, como parte del estudio de un nódulo cervical, que visualiza un tumor sólido y redondeado, localizado en el istmo, de 4 mm de diámetro, sin presencia de adenopatías. Sus pruebas tiroideas muestran TSH y T4 libre dentro de rangos normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar tratamiento levotiroxina
B) Iniciar levotiroxina en dosis de supresión
C) Realizar punción con aguja fina
D) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
E) Realizar seguimiento ecográfico

Respuesta E. Un nódulo de 4 mm, sin adenopatías y con función tiroidea normal, no alcanza ningún umbral de PAAF: se vigila con ecografía. La levotiroxina supresora está en desuso y el cintigrama no se pide con TSH normal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 146

Una paciente de 42 años, consulta por adenopatía supraclavicular derecha persistente. Al examen físico se palpa además un nódulo cervical paratraqueal derecho de consistencia aumentada, que asciende con la deglución, de alrededor de 2 cm de diámetro. **¿Cuál es el examen de elección para iniciar el estudio de esta paciente?**

A) Niveles plasmáticos de calcitonina
B) Ecografía cervical
C) TAC de cuello
D) Resonancia magnética de cuello
E) Biopsia quirúrgica

Respuesta B. Un nódulo que asciende con la deglución es tiroideo, y junto a una adenopatía persistente sugiere cáncer con diseminación linfática. Aun así, el estudio parte con ecografía cervical, que caracteriza el nódulo y los ganglios y guía la punción. La calcitonina no es el examen inicial.

Pregunta de práctica

Hombre de 39 años, sin antecedentes familiares ni de radiación. Nódulo tiroideo de 2 cm, TSH normal, clasificado como TI-RADS 4. Se realiza PAAF guiada por ecografía, cuyo informe concluye: Bethesda IV, neoplasia folicular. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control ecográfico en 6 meses
B) Hemitiroidectomía (lobectomía más istmectomía) diagnóstica
C) Tiroidectomía total con vaciamiento ganglionar bilateral
D) Radioyodo I-131 en dosis ablativa
E) Repetir la PAAF con aguja de mayor calibre

Respuesta B. Bethesda IV tiene un riesgo de cáncer de 25–40 %, y la citología no distingue adenoma de carcinoma folicular: eso exige ver invasión capsular o vascular en la pieza completa. La conducta es la hemitiroidectomía diagnóstica; si la histología confirma carcinoma, se completa la tiroidectomía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 51 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 30 años presenta un cuadro de astenia y piel seca. Al examen se detecta un nódulo tiroideo, que se palpa de 15 mm de diámetro, en relación al lóbulo derecho. Se solicita TSH y T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

A) Ecografía cervical
B) Biopsia citológica por punción con aguja fina
C) Biopsia excisional
D) Cintigrafía tiroidea
E) Captación de yodo radiactivo

Respuesta A. El estudio de un nódulo tiroideo con TSH normal comienza con la ecografía cervical, que describe tamaño, características sospechosas y guía la punción con aguja fina. La captación de yodo radiactivo y la cintigrafía solo se usan si la TSH está suprimida, y la biopsia excisional no es un examen inicial.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 154 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con antecedente de AVE isquémico; en ecografía Doppler carotídeo se ve nódulo tiroideo de 10 mm, quístico, bordes regulares, sin vascularización. ¿Cuál es la conducta?

A) PAAF del nódulo
B) Cintigrafía tiroidea
C) Derivar a cirugía de cuello
D) Controlar con ecografía en un año
E) TSH y T4 libre

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Controlar con ecografía en un año (opción D). Controlar con ecografía en un año. Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 16 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 32 años, con antecedente de familiar con cáncer de tiroides, acude a la consulta. Trae una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro de aspecto quístico, sin calcificaciones, con presencia de adenopatías inespecíficas pequeñas. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar punción aspiración con aguja fina
B) Solicitar cintigrafía tiroidea
C) Solicitar captación de yodo radiactivo
D) Solicitar nueva ecografía en 6 meses
E) Realizar tiroidectomía

Respuesta D. Los nódulos menores a 10 mm, en especial si son quísticos, se observan, debido a que con altísima probabilidad son un quiste coloideo. Se controla ecográficamente en 6 meses.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 23 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 32 años, con antecedente de madre con cáncer de tiroides, por lo que se realiza una ecografía cervical, que muestra un nódulo tiroideo de 7 mm de diámetro y aspecto quístico. Su TSH y T4 libre son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Realizar punción aspiración con aguja fina
B) Solicitar cintigrafía tiroidea
C) Solicitar captación de yodo radiactivo
D) Solicitar nueva ecografía en 6 meses
E) Realizar tiroidectomía

Respuesta D. Todo nódulo tiroideo se estudia con Ecografía y TSH + T4L. Si tiene más de 10 mm, se punciona con PAAF. Si tiene menos de 10 mm, se sigue (este caso). Si tiene TSH baja (hipertiroidismo) se estudia con cintigrafía toroidea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 101 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 59 años, fumador, presenta un accidente vascular encefálico, que se maneja rápidamente, por lo que se recupera sin dejar secuelas. Posteriormente, se realiza ecografía Doppler carotidea como estudio de fuente embólica, que no muestra alteraciones arteriales, pero sí identifica la presencia de un nódulo tiroideo de 1 cm de diámetro, de aspecto quístico, bien delimitado y capsulado. Se solicitan pruebas tiroideas que muestran TSH: 2,1 microU/ml (VN: 0,5 a 5,0) y T4 libre que resulta 1,2 ng/dl (VN: 0,9 a 2,2). ¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del nódulo tiroideo?

A) Realizar punción con aguja fina
B) Controlar en 6 meses con nueva ecografía
C) Solicitar cintigrafía con yodo radiactivo
D) Iniciar levotiroxina
E) Realizar biopsia excisional quirúrgica

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Realizar punción con aguja fina (opción A). Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 22 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 28 años, fumador, consulta por aumento de volumen cervical. Al examen físico se palpa nódulo paratraqueal derecho, de 3 cm de diámetro y consistencia aumentada, que asciende con la deglución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Quiste tirogloso
B) Quiste branquial
C) Cáncer de laringe
D) Adenopatía metastásica
E) Nódulo tiroideo

Respuesta E. Ascienden con la deglución solo la el QTG y el nódulo tiroideo. Pero el QTG está en la línea media y no en el lado derecho, como este caso.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 92 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 37 años, sin antecedentes, consulta por aparición de aumento de volumen cervical anterior, no asociado a otros síntomas. Al examen físico destaca nódulo a nivel tiroídeo de consistencia aumentada, que asciende a la deglución. Como parte del estudio se realiza TSH que resulta normal. La conducta inicial más adecuada en este caso es:

A) Solicitar punción con aguja fina
B) Solicitar Cintigrafía con I131
C) Solicitar ecografía cervical
D) Solicitar anticuerpos anti tiroperoxidasa
E) Solicitar niveles de T3 y T4L

Respuesta C. Eco y PAAF son respuestas correctas. Como no dice el tamaño, primero la ecografía, para ver el aspecto y descartar adenopatías. Así lo dice la guía minsal.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 25 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años presenta un nódulo tiroideo de 2 cm de diámetro, a la palpación. Se solicita TSH t T4 libre, que resultan normales. ¿Cuál es el examen de elección para continuar el estudio de esta paciente?

A) Ecografía cervical
B) Punción aspiración con aguja fina
C) Anticuerpos antiroideos
D) Cintigrafía con yodo radiactivo
E) TAC cervical

Respuesta A. Ante un nódulo tiroideo, lo primero es pedir TSH, luego la ecografía y luego la punción con aguja fina (si es mayor a 10 mm).

1.03.1.022 Incidentaloma suprarrenal

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.15 Feocromocitoma y Paragangliomas: Bloqueo Alfa Obligatorio

QUÉ HAY QUE SABER

- Masa suprarrenal ≥1 cm hallada en una imagen solicitada por otro motivo; la mayoría son adenomas no funcionantes.
- Todo incidentaloma requiere estudio funcional: test de supresión con 1 mg de dexametasona (Cushing subclínico) y metanefrinas plasmáticas o urinarias (feocromocitoma); aldosterona y renina si hay HTA o hipokalemia.
- Imagen: <10 UH sin contraste, homogéneo y de bordes nítidos sugiere adenoma rico en lípidos; tamaño >4 cm, heterogéneo, >10 UH o lavado lento sugiere carcinoma o feocromocitoma.
- No biopsiar: no distingue adenoma de carcinoma y es peligrosa si es feocromocitoma (salvo sospecha de metástasis, descartado antes el feocromocitoma).
- Derivar a endocrinología o cirugía si es funcionante, mide >4 cm o tiene imagen sospechosa (suprarrenalectomía); no funcionante pequeño y benigno, control clínico según especialista.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

A una mujer de 55 años, normotensa, se le encuentra en una TAC solicitada por cólico renal una masa suprarrenal izquierda de 2,5 cm, homogénea, de 8 UH sin contraste. No tiene signos de síndrome de Cushing. **¿Cuál es el estudio hormonal mínimo más adecuado?**

A) Ningún estudio, por ser pequeño y homogéneo
B) Test de supresión con 1 mg de dexametasona y metanefrinas plasmáticas o urinarias
C) Solo cortisol libre urinario
D) Biopsia percutánea de la masa
E) Solo aldosterona y renina plasmáticas

Respuesta B. Todo incidentaloma suprarrenal requiere estudio funcional: supresión nocturna con 1 mg de dexametasona (Cushing subclínico) y metanefrinas (feocromocitoma); aldosterona y renina se agregan si hay HTA o hipokalemia. Menos de 10 UH sugiere adenoma rico en lípidos. La biopsia no se recomienda y es peligrosa si es feocromocitoma.

1.03.1.023 Ginecomastia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: endo-25

QUÉ HAY QUE SABER

- Ginecomastia: proliferación del tejido glandular mamario masculino (disco retroareolar firme, a menudo doloroso y bilateral); diferenciar de la pseudoginecomastia (grasa) y del cáncer de mama (unilateral, duro, excéntrico, fijo, con retracción o secreción).
- Fisiológica en recién nacidos, adolescentes (suele regresar en 6–24 meses) y adultos mayores. Patológica: fármacos (espironolactona, ketoconazol, antiandrógenos, cimetidina, anabólicos, marihuana), cirrosis, enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, hipogonadismo (Klinefelter) y tumores productores de estrógenos o hCG (testicular).

- Estudio: anamnesis farmacológica y examen testicular; si no es fisiológica o es reciente o progresiva, pedir testosterona, LH, FSH, estradiol, beta-hCG, prolactina, TSH, perfil hepático y creatinina; ecografía testicular si hay hCG o estradiol alto o masa.
- Ecografía o mamografía si hay sospecha de cáncer de mama; en adolescentes con examen normal basta la observación y tranquilizar.
- Inicial: suspender el fármaco causal y tratar la causa. Derivar: masa sospechosa, tumor testicular, hipogonadismo, ginecomastia de >12 meses o con impacto estético (tamoxifeno precoz o cirugía por especialista).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 45**
> Adolescente masculino de 14 años con aumento bilateral del tejido mamario subareolar, sensible al tacto, sin secreción. No usa medicamentos. Su desarrollo puberal es Tanner 3. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta más adecuados?**
> **A)** Ginecomastia puberal fisiológica; tranquilizar y observar
> **B)** Cáncer de mama masculino; biopsia urgente
> **C)** Hiperprolactinemia; solicitar prolactina
> **D)** Hipogonadismo; solicitar testosterona
> **E)** Tumor testicular; solicitar ecografía testicular
> Respuesta A. La ginecomastia puberal aparece en la mitad o más de los varones en Tanner 2 a 4; es bilateral, subareolar, a veces sensible, y regresa sola en 1 a 2 años. Se examinan los testículos y se revisan fármacos o drogas; si todo es normal, basta tranquilizar y controlar. El cáncer de mama es excepcional a esta edad.

Situaciones clínicas de urgencia 5 códigos

1.03.2.001 Tormenta tiroidea

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.8 Tormenta Tiroidea y Urgencias Tirotóxicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Tormenta tiroidea: hipertiroidismo (habitualmente Graves no controlado) descompensado por un gatillante: infección, cirugía sin preparación, abandono de tionamidas, contraste yodado, parto o cetoacidosis.
- Diagnóstico clínico, sin esperar la T4 libre: fiebre, taquicardia o FA, insuficiencia cardíaca, compromiso del SNC (agitación, delirio, coma) y digestivo (vómitos, diarrea, ictericia). Burch-Wartofsky ≥45 altamente probable; 25–44 inminente.
- Manejo en UCI con cuatro pilares: 1) propranolol 60–80 mg c/4–6 h oral (o 1–2 mg EV); 2) propiltiouracilo carga 500–1.000 mg y luego 200–250 mg c/4 h; 3) Lugol 8–10 gotas c/8 h al menos 1 hora después del PTU; 4) hidrocortisona 100 mg EV c/8 h.
- Soporte: paracetamol y enfriamiento físico (aspirina contraindicada: libera T4 de la TBG), fluidos con suero glucosado y fisiológico; buscar y tratar el gatillante (cultivos, antibióticos).
- Refractaria a 24–48 h: plasmaféresis o tiroidectomía de salvataje. Seguimiento: derivar a UCI y endocrinología.

PREGUNTAS (4)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 46 años con hipertiroidismo reciente, en tratamiento irregular con tiamazol, con 3 días de tos productiva. Llega soporosa, sudorosa, T° 39,8 °C, PA 85/50 mmHg, FC 152 lpm en fibrilación auricular. Bocio difuso con soplo, crepitaciones bibasales e ictericia leve. Burch-Wartofsky: 75 puntos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Solicitar T4 libre y T3 y esperar el resultado antes de iniciar tratamiento
> **B)** Traslado a UCI e inicio inmediato de tratamiento multimodal, más antibióticos para la neumonía
> **C)** Solicitar cintigrama tiroideo para confirmar la etiología
> **D)** Aumentar el tiamazol y controlar en 48 horas en sala
> **E)** Administrar radioyodo en dosis ablativa
> Respuesta B. Burch-Wartofsky de 75 puntos (≥ 45): tormenta tiroidea desencadenada por una neumonía. El diagnóstico es clínico y el tratamiento no se retrasa por exámenes: UCI, propranolol, PTU, Lugol 1 hora después del PTU, hidrocortisona EV, paracetamol y medidas físicas, reanimación y antibióticos empíricos.

Pregunta de práctica

Mujer de 50 años con hipertiroidismo de Graves no controlado consulta en urgencias por fiebre de 39,5 °C, agitación psicomotora, náuseas, vómitos profusos y palpitaciones. ECG: taquicardia sinusal a 145 lpm. Escala de Burch-Wartofsky: 60 puntos. **¿Cuál de las siguientes secuencias y combinaciones de fármacos representa el manejo médico correcto?**

A) Ácido acetilsalicílico 1 g EV de inmediato, seguido de tiamazol 10 mg oral
B) Propranolol, propiltiouracilo a dosis altas, hidrocortisona EV y solución de Lugol al menos una hora después del propiltiouracilo
C) Solución de Lugol en bolo endovenoso inmediato y levotiroxina en infusión
D) Tiroidectomía total de urgencia en los primeros 30 minutos sin fármacos previos
E) Radioyodo a dosis máxima como terapia ablativa urgente

Respuesta B. Tratamiento multimodal: betabloqueo, PTU (bloquea síntesis y conversión periférica), hidrocortisona EV (insuficiencia suprarrenal relativa) y Lugol diferido al menos 1 hora tras el PTU para evitar el efecto Jod-Basedow. Los salicilatos están contraindicados.

Pregunta de práctica

En un paciente cursando una tormenta tiroidea con hipertermia de 40,2 °C y compromiso sensorial en la unidad de cuidados intensivos, el residente de turno planea indicar un antipirético. **¿Cuál de los siguientes antipiréticos está formalmente contraindicado por el riesgo de aumentar la hormona tiroidea libre?**

A) Paracetamol
B) Dipirona (metamizol)
C) Ácido acetilsalicílico (aspirina)
D) Ibuprofeno
E) Ketorolaco

Respuesta C. Los salicilatos desplazan a la T4 y la T3 de la TBG y la transtiretina, aumentando bruscamente la fracción libre y agravando la tormenta. El antipirético de elección es el paracetamol con medidas físicas.

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años con enfermedad de Graves en abandono de tratamiento ingresa a urgencias con shock distributivo, agitación extrema, diaforesis, ictericia y fibrilación auricular rápida a 160 lpm. Burch-Wartofsky: 65 puntos. **¿Cuál es el fundamento fisiopatológico principal para administrar hidrocortisona endovenosa en el esquema inicial?**

A) Tratar la insuficiencia suprarrenal relativa por metabolismo acelerado del cortisol y frenar la conversión periférica de T4 a T3
B) Inducir inmunosupresión inmediata de los TRAb en menos de 2 horas
C) Elevar la TSH hipofisaria y restablecer el asa de retroalimentación
D) Favorecer la captación folicular de yodo inorgánico
E) Evitar la hipoglicemia provocada por el propiltiouracilo

Respuesta A. El hipermetabolismo acelera la degradación del cortisol y supera la reserva suprarrenal (insuficiencia suprarrenal relativa). La hidrocortisona a dosis de estrés previene el colapso hemodinámico y además inhibe la desyodasa periférica, frenando la conversión de T4 a T3.

1.03.2.002 Mixedema

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 1.3 Coma Mixedematoso y Urgencias Hipotiroideas

QUÉ HAY QUE SABER

- Coma mixedematoso: hipotiroidismo grave no tratado o abandonado más un gatillante (frío invernal, infección, sedantes u opioides, ACV o infarto); típico en mujer de edad avanzada; mortalidad 30–50 %.
- Clínica: hipotermia <35 °C (termómetro rectal), sopor o coma, bradicardia, hipotensión refractaria a volumen e hipoventilación con hipercapnia; hiponatremia, hipoglicemia, CK alta y anemia.
- Confirmación: TSH muy alta (>50–100) con T4 libre indetectable (TSH baja si es central), pero el tratamiento no espera el resultado.
- Hidrocortisona 100 mg EV en bolo y luego 100 mg c/8 h antes o junto con levotiroxina EV de carga 300–500 mcg y luego 50–100 mcg/día (vía oral no sirve por íleo).
- Soporte: recalentamiento pasivo (no activo), intubación si hay hipercapnia, restricción hídrica (NaCl 3 % si Na <120 sintomático), y buscar y tratar el gatillante con cultivos y antibióticos. Derivar a UCI.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 153

Paciente con piel seca, bradicardia, hipotensión, compromiso de conciencia, TSH 100 y T4 libre muy baja. **¿Diagnóstico?**

A) Coma mixedematoso
B) Hipotiroidismo subclínico severo
C) Insuficiencia suprarrenal aguda
D) Encefalopatía hipoglucémica
E) Hipotiroidismo primario descompensado

Respuesta A. Hipotiroidismo grave (TSH 100, T4 libre muy baja) con compromiso de conciencia, bradicardia e hipotensión: coma mixedematoso. El compromiso de conciencia y la inestabilidad hemodinámica lo separan de un hipotiroidismo descompensado sin urgencia vital.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 30

Una paciente de 46 años, con antecedentes de anemia perniciosa y vitíligo, es traída al servicio de urgencia por un cuadro de malestar general y desorientación. Sus familiares relatan que ha presentado compromiso del estado general y astenia de 3 semanas de evolución, asociando recientemente a somnolencia y desorientación. Al examen físico está en sopor superficial y sus signos vitales muestran presión arterial: 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca: 62 lpm, temperatura: 36 °C. En el examen segmentario se objetiva lengua de gran tamaño y edema de extremidades inferiores. Al examen neurológico está soporosa, no tiene focalidad neurológica y se observa enlentecimiento de la fase de relajación de los reflejos osteotendíneos. Los exámenes de laboratorio muestran sodio: 130 mEq/L, hemoglobina: 10 g/dl, hematocrito: 31%, VCM 102 fL, glóbulos blancos: 5.200/mm³ y plaquetas: 180.000/mm³. Se solicita TAC de cerebro, que no muestra alteraciones. **¿Cuál es el tratamiento inicial más adecuado?**

A) Suero hipertónico endovenoso
B) Suero fisiológico endovenoso
C) Levotiroxina endovenosa
D) Corticoides endovenosos
E) Antibióticos endovenosos

Respuesta D. Coma mixedematoso en una tiroiditis autoinmune (vitíligo y anemia perniciosa sugieren autoinmunidad poliglandular). La primera medida son los corticoides EV, seguidos de la levotiroxina EV: darla sola puede precipitar una insuficiencia suprarrenal aguda.

Pregunta de práctica

Mujer de 78 años con hipotiroidismo en abandono de tratamiento, encontrada inconsciente en su casa durante una ola de frío. En urgencia: coma, piel fría y engrosada, temperatura rectal 31,8 °C, FC 42 lpm, PA 80/50 mmHg, FR 8 rpm. Glicemia 55 mg/dL, Na 118 mEq/L, acidosis respiratoria hipercápnica, TSH > 100 mUI/L y T4 libre indetectable. **Además de intubarla, ¿cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Levotiroxina 500 mcg EV y esperar el cortisol sérico antes de dar corticoides
B) Hidrocortisona 100 mg EV antes o junto con la carga de levotiroxina EV, y recalentamiento pasivo
C) Baño de inmersión en agua caliente y levotiroxina oral
D) Hemodiálisis de urgencia por la hiponatremia
E) Levotiroxina 25 mcg oral y subir lentamente cada 6 semanas

Respuesta B. Coma mixedematoso gatillado por frío: hipotermia, coma, bradicardia, hipotensión, hipoventilación, hiponatremia e hipoglicemia. Se da hidrocortisona 100 mg EV antes o junto con la levotiroxina EV de carga, sin esperar el cortisol, con recalentamiento pasivo.

1.03.2.003 Insuficiencia suprarrenal aguda

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.13 Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis suprarrenal: shock desproporcionado y refractario a volumen y noradrenalina, compromiso de conciencia, dolor abdominal y vómitos (simula abdomen agudo), a veces fiebre.
- Gatillantes: infección intercurrente (la causa n.º 1), gastroenteritis con vómitos, suspensión brusca de corticoides o no subir la dosis ante estrés, cirugía o trauma; debut por hemorragia suprarrenal bilateral (Waterhouse-Friderichsen en meningococcemia, antifosfolípido).
- Laboratorio: hiponatremia, hiperkalemia (solo en la primaria), hipoglicemia, acidosis metabólica y azoemia prerrenal. Tomar cortisol, ACTH y electrolitos pero no esperar el resultado.

- Tratamiento: hidrocortisona 100 mg EV en bolo en el minuto cero, suero fisiológico 1–2 L en las primeras 2 h y suero glucosado para la hipoglicemia; dexametasona 4–6 mg EV si no hay hidrocortisona.
- Mantención: hidrocortisona 50 mg c/6 h (o 200 mg/24 h) por 24–48 h y descenso gradual a vía oral; fludrocortisona solo en Addison al bajar de 50 mg/día. Buscar y tratar el gatillante (cultivos, antibióticos). Seguimiento: derivar a endocrinología y educar dosis de estrés.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 20

Un paciente tiene diarrea de 3 días de evolución, asociada a malestar general marcado y vómitos alimentarios, con deterioro del estado general. Al examen físico se observa deshidratado, con FC: 110 x', PA: 70/40 mmHg, abdomen doloroso, sin irritación peritoneal. Se solicitan exámenes, entre los que destacan Na+: 126 mEq/L, K+: 4,7 mEq/L, glicemia: 58 mg/dl, PCR: 4,0, blancos: 12.000 por mm3, creatinina 2,3 mg/dl. Se administran 3 litros de suero fisiológico, sin lograr estabilizar al paciente. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Insuficiencia renal aguda
B) Shigelosis
C) Peritonitis aguda
D) Insuficiencia suprarrenal aguda
E) Accidente vascular hemorrágico

Respuesta D. Shock refractario a 3 litros de suero, hiponatremia, hipoglicemia y potasio en el límite alto, con dolor abdominal sin irritación peritoneal: crisis suprarrenal clásica. La creatinina elevada es azoemia prerrenal por hipoperfusión, no el diagnóstico principal.

Pregunta de práctica

Hombre de 39 años con enfermedad de Addison en tratamiento con hidrocortisona y fludrocortisona. Hace 48 horas inicia vómitos y diarrea, sin tolerar sus comprimidos. Llega soporoso, febril (38,8 °C), PA 70/40 mmHg, FC 130 lpm, con dolor abdominal difuso sin peritonismo e hiperpigmentación en manos y mucosa oral. HGT 48 mg/dL. **¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada?**

A) Solicitar cortisol plasmático y ACTH, y tratar según resultado
B) Hidrocortisona 100 mg EV en bolo + suero fisiológico y suero glucosado
C) Iniciar noradrenalina y solicitar TAC de abdomen
D) Fludrocortisona oral y aumentar la hidrocortisona oral al doble
E) Laparotomía exploradora por abdomen agudo

Respuesta B. Crisis suprarrenal gatillada por gastroenteritis con intolerancia oral: shock, compromiso de conciencia, dolor abdominal e hipoglicemia. Se trata de inmediato con hidrocortisona 100 mg EV en bolo, suero fisiológico y suero glucosado, sin esperar exámenes. La fludrocortisona no se usa en la fase aguda y la vía oral no sirve con vómitos.

1.03.2.004 Hipercalcemia aguda

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante calcio corregido ≥12–14 mg/dL con poliuria, deshidratación, náuseas, vómitos, constipación, debilidad, confusión o estupor, arritmias y QT corto; causas principales: neoplasias (PTHrP, osteólisis) e hiperparatiroidismo primario.
- Severidad: leve <12 (hidratación oral), moderada 12–13,9 (hospitalizar), crisis ≥14 o con compromiso neurológico, arritmias o falla renal (UCI).
- Primer pilar: suero fisiológico 0,9 % 200–300 mL/h (2–4 L en 24 h); furosemida solo una vez euvolémico o con sobrecarga, nunca antes de hidratar.
- Ácido zoledrónico 4 mg EV en 15 min (efecto en 48–72 h) y calcitonina de salmón como puente (actúa en 4–6 h); corticoides si es por linfoma, mieloma, sarcoidosis o exceso de vitamina D; hemodiálisis si hay falla renal refractaria.
- Pedir PTH antes de tratar para orientar la causa. Seguimiento: derivar para estudio etiológico (búsqueda de cáncer o paratiroidectomía).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 123

Un paciente de 76 años, con antecedente de cáncer de próstata avanzado, presenta un cuadro de 2 días de evolución de debilidad y malestar general, al que se agrega obnubilación de conciencia y tendencia al sopor. Al examen físico se aprecia desorientado, con sopor profundo, sin focalidad neurológica, tiene FC: 80x', PA: 150/100 mmHg y FR: 16x'. El examen torácico y abdominal no aporta mayor información. Se solicitan electrolitos plasmáticos que muestran sodio: 148 mEq/L, potasio: 5 mEq/L, calcio: 14,8 mg/dl y otros exámenes de sangre que muestran creatinina: 1,4 mg/dl, GOT: 50 UI/l, 2, APE: 200 ng/ml. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Administrar calcitonina endovenosa
B) Realizar hemodiálisis de urgencia
C) Administrar ácido zolendrónico endovenoso
D) Administrar gluconato de calcio endovenoso
E) Administrar suero fisiológico endovenoso

Respuesta E. Calcio de 14,8 mg/dL con sopor: crisis hipercalcémica maligna. La primera medida es la expansión de volumen con suero fisiológico, que restaura la filtración e induce calciuresis. El zoledronato va después (demora 48–72 h y requiere hidratación previa); la calcitonina es puente; la hemodiálisis se reserva para falla renal anúrica o refractariedad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 79

Hombre de 55 años con hipercalcemia severa (Ca 13.5 mg/dL), náuseas, poliuria, confusión y deshidratación. PTH elevada. **¿Cuál es el tratamiento inicial de urgencia?**

A) Resonancia magnética
B) Cintigrafía con sestamibi (localización de adenoma paratiroideo)
C) Hidratación EV con solución salina 0.9%
D) Paratiroidectomía de urgencia
E) Carbonato de calcio oral

Respuesta C. Hipercalcemia sintomática con deshidratación: el tratamiento de urgencia es la hidratación EV con suero fisiológico al 0,9 %, aunque la causa sea un hiperparatiroidismo. El sestamibi y la paratiroidectomía se planifican de forma electiva, una vez estabilizado.

1.03.2.005 Tetania

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 7.17 Hipocalcemia Aguda y Crónica: Diagnóstico y Manejo de Emergencia

QUÉ HAY QUE SABER

- Tetania por hipocalcemia (calcio corregido <8,5 o iónico <4,0 mg/dL): causa n.º 1 el hipoparatiroidismo 24–72 h post tiroidectomía; también hipomagnesemia severa, pancreatitis, sepsis y transfusión masiva.
- Clínica: parestesias periorales y distales (signo más precoz), espasmo carpopedal, hiperreflexia, laringoespasmo con estridor y convulsiones; signos de Chvostek y Trousseau (más sensible y específico); ECG con QT prolongado.
- Tratamiento: gluconato de calcio 10 % 1–2 ampollas EV en 10–20 min con monitor, seguido de infusión (10 ampollas en 1.000 mL de SG 5 %); preferir gluconato a cloruro por riesgo de necrosis si se extravasa.
- Si no responde: medir y reponer magnesio (sulfato de magnesio 1–2 g EV en 20 min); sin magnesio no se secreta ni actúa la PTH.
- Mantención en hipoparatiroidismo: carbonato de calcio 1–3 g/día con las comidas + calcitriol 0,25–1 mcg/día (el colecalciferol no sirve), meta de calcio 8,0–8,5. Seguimiento: derivar a endocrinología.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 82

Una mujer de 29 años, con antecedente de tiroidectomía por cáncer de tiroides hace 5 meses, consulta por síntomas de una semana de evolución, consistentes en astenia, nerviosismo y palpitaciones, que han ido en aumento. Además, el día de hoy presentó convulsiones en una oportunidad, por lo que fue traída al Servicio de Urgencia. Al examen físico está en Glasgow 15, sin convulsiones actuales ni focalidad neurológica. Se solicitan exámenes de laboratorio, entre los que destacan glicemia: 120 mg/dl, potasemia: 4,0 mEq/l, natremia: 144 mEq/L, calcemia 6,3 mg/dl, fósforo: 5,5 mg/dl, albúmina: 3,9 g/dl y hematocrito: 48%. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada en esta paciente?**

A) Administrar suero fisiológico
B) Solicitar TAC de cerebro
C) Administrar calcio endovenoso
D) Administrar lorazepam endovenoso
E) Administrar calcitonina

Respuesta C. Tiroidectomía reciente, calcio bajo con fósforo alto y albúmina normal: hipocalcemia por hipoparatiroidismo postquirúrgico, sintomática (convulsión). La conducta inicial es gluconato de calcio endovenoso.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 110

Paciente con tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, presenta debilidad, parestesias y signo de Chvostek positivo. **¿Cuál es el tratamiento inicial?**

A) Calcitriol oral más calcio oral
B) Gluconato de calcio endovenoso
C) Carbonato de calcio 1 g oral
D) PTH recombinante subcutáneo
E) Terlipresina endovenosa

Respuesta B. Parestesias con Chvostek positivo en un paciente sin paratiroides: hipocalcemia sintomática. El tratamiento inicial es gluconato de calcio EV. El calcio oral con calcitriol es el tratamiento de mantención, no el rescate.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 25

Un paciente, con antecedente de tiroidectomía total e hipoparatiroidismo, en tratamiento con levotiroxina, calcio y vitamina D, por vía oral, presenta diarrea aguda, de 2 días de evolución, abundante. Evoluciona con astenia, marcada debilidad, dolor en las extremidades inferiores y calambres. Al examen físico tiene reflejos osteotendíneos vivos y signo de Chvostek positivo. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Suero fisiológico endovenoso
B) Gluconato de calcio endovenoso
C) Suero glucosado con potasio endovenoso
D) Suero Ringer endovenoso
E) Hidrocortisona endovenosa

Respuesta B. Un hipoparatiroideo que depende del calcio oral deja de absorberlo con la diarrea y cae en hipocalcemia sintomática: calambres, hiperreflexia y Chvostek positivo. Conducta inicial: gluconato de calcio EV.

Conocimientos generales 3 códigos

1.03.3.001 Pubertad normal

Dónde se enseña: Tema 20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- En niñas la pubertad normal comienza entre los 8 y 13 años; el primer signo es la telarquia (botón mamario, puede ser unilateral y sensible), seguida de pubarquia, estirón puberal y menarquia unos 2 años después de la telarquia.
- En niños comienza entre los 9 y 14 años; el primer signo es el aumento del volumen testicular (≥4 mL), luego pubarquia, crecimiento del pene y el estirón, que en ellos es más tardío.
- Se evalúa con los estadios de Tanner (mamas o genitales y vello púbico) y la curva de talla y velocidad de crecimiento.
- Pubertad precoz: antes de los 8 años en niñas y de los 9 en niños, derivar a endocrinología infantil. Retraso puberal: sin telarquia a los 13 años en niñas o sin aumento testicular a los 14 en niños.
- Variantes normales que no requieren estudio: telarquia prematura aislada en lactantes, ginecomastia puberal transitoria en varones adolescentes.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una niña de 10 años es llevada a control porque la madre notó un 'bultito' bajo la areola derecha hace 2 meses, levemente sensible. No tiene vello púbico ni ha menstruado. Su crecimiento es normal. **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**

A) Pubertad precoz que requiere estudio urgente
B) Tumor mamario que requiere biopsia
C) Inicio normal de la pubertad: la telarquia es el primer signo puberal en las niñas
D) Ginecomastia
E) Hiperprolactinemia

Respuesta C. En niñas la pubertad normal comienza entre los 8 y 13 años, y su primer signo es la telarquia (botón mamario), que puede ser unilateral y sensible al inicio. Luego vienen pubarquia, estirón y menarquia. En niños el primer signo es el aumento testicular (≥4 mL). Pubertad precoz en niñas es antes de los 8 años.

1.03.3.002 Prevención de osteoporosis

Dónde se enseña: Tema 7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención para toda la población, sobre todo mujeres posmenopáusicas: calcio 1.000–1.200 mg/día idealmente con la dieta (lácteos) y vitamina D suficiente (800–2.000 UI/día si hay déficit o poca exposición solar).
- Ejercicio con carga y de fuerza, suspender el tabaco, moderar el alcohol (<3 unidades/día) y mantener un IMC >20.
- Prevención de caídas en adultos mayores: revisar fármacos sedantes, corregir la visión, adaptar el hogar y entrenar el equilibrio.
- Osteopenia con FRAX bajo no requiere fármacos: medidas generales y DEXA de control en 2–3 años. Tamizaje con DEXA en mujeres ≥65 años o con factores de riesgo.
- Usuarios de corticoides crónicos: dosis mínima eficaz, calcio y vitamina D, y evaluar bifosfonato si reciben prednisona ≥5–7,5 mg/día por más de 3 meses.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 54 años, menopáusica hace 3 años, fumadora de 10 cigarrillos al día, sedentaria, IMC 21. Ingiere un solo lácteo al día. Sin fracturas previas ni uso de corticoides. Su densitometría muestra T-score –1,4 en columna y –1,2 en cadera, con riesgo de fractura a 10 años bajo según FRAX. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A) Alendronato 70 mg semanal
B) Asegurar 1.000–1.200 mg/día de calcio, idealmente con la dieta, vitamina D, ejercicio con carga, suspender el tabaco y moderar el alcohol
C) Ácido zoledrónico anual
D) Solo control densitométrico en 6 meses
E) Calcitonina nasal

Respuesta B. Osteopenia con riesgo de fractura bajo: no tiene indicación de fármacos antirresortivos. Corresponde la prevención: aporte de calcio de 1.000–1.200 mg/día, idealmente con la dieta, vitamina D suficiente, ejercicio con carga y de fuerza, dejar el tabaco, moderar el alcohol y prevenir caídas. La densitometría de control se repite en 2 a 3 años, no a los 6 meses.

1.03.3.003 Complicaciones del tratamiento esteroidal

Dónde se enseña: Tema 7.13 Crisis Suprarrenal Aguda y Shock Refractario

QUÉ HAY QUE SABER

- Supresión del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal con dosis suprafisiológicas por más de 3 semanas: la suspensión brusca causa insuficiencia suprarrenal aguda (hipotensión, vómitos, hiponatremia); retirar siempre en forma gradual y dar dosis de estrés ante enfermedad o cirugía.
- Cushing iatrogénico: obesidad central, cara de luna, estrías, equimosis, miopatía proximal, HTA, hiperglicemia o diabetes y dislipidemia.
- Osteoporosis inducida por corticoides (la causa secundaria más frecuente): calcio, vitamina D y bifosfonato si prednisona ≥5–7,5 mg/día por más de 3 meses; también necrosis avascular de cadera.
- Infecciones (incluida reactivación de TBC: tamizar antes de dosis altas prolongadas), úlcera péptica con AINE, cataratas, glaucoma, alteraciones psiquiátricas (euforia, insomnio, psicosis) y retraso del crecimiento en niños.

- Prevención: dosis mínima eficaz por el menor tiempo posible, preferir vía local (inhalada, tópica, intraarticular) y vigilar PA, glicemia, densitometría y presión ocular.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un hombre de 60 años usa prednisona 20 mg/día desde hace 8 meses por una enfermedad pulmonar intersticial. Suspendió el fármaco bruscamente hace 4 días por miedo a sus efectos adversos. Consulta por náuseas, vómitos y debilidad intensa. PA 80/50 mmHg, natremia 131 mEq/L. **¿Cuál es la complicación más probable y su manejo?**
> **A)** Síndrome de Cushing: suspender corticoides
> **B)** Hipotiroidismo: levotiroxina
> **C)** Hiperaldosteronismo: espironolactona
> **D)** Feocromocitoma: bloqueo alfa
> **E)** Insuficiencia suprarrenal aguda secundaria por supresión del eje: hidrocortisona endovenosa y volumen
> Respuesta E. Los corticoides en dosis suprafisiológicas por más de 3 semanas suprimen el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, y su suspensión brusca puede causar insuficiencia suprarrenal aguda. Se trata con hidrocortisona endovenosa (100 mg en bolo) y suero fisiológico, sin esperar exámenes. Por eso los corticoides prolongados se retiran en forma gradual.

Exámenes e imagenología 11 códigos

1.03.4.001 Ecografía tiroídea

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 7.9 Nódulo Tiroideo, Clasificación ACR TI-RADS y Criterios de PAAF

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: nódulo palpable o incidental, bocio, adenopatías cervicales, seguimiento de nódulos y de cáncer de tiroides operado.
- Es el examen que estratifica el riesgo del nódulo mediante TI-RADS; no reemplaza la TSH, que va primero.
- Hallazgos de alta sospecha (TR5): sólido, marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, márgenes irregulares o extensión extratiroidea, microcalcificaciones. Benignidad: espongiforme o quiste simple anecoico.
- Conducta según informe: PAAF guiada en TR3 ≥2,5 cm, TR4 ≥1,5 cm y TR5 ≥1 cm; bajo el umbral, seguimiento ecográfico; TR1–TR2 no se punciona.
- Otros hallazgos: Hashimoto da tiroides heterogénea e hipoecogénica; Graves, glándula aumentada e hipervascular; adenopatías sospechosas obligan a PAAF del ganglio y derivación.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 44 años, eutiroidea (TSH 1,8 mUI/L), sin antecedentes de radiación. Se palpa un nódulo en el lóbulo izquierdo. La ecografía tiroidea muestra un nódulo sólido de 1,3 cm, marcadamente hipoecogénico, más alto que ancho, de bordes irregulares y con microcalcificaciones, sin adenopatías cervicales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Control ecográfico en 12 meses, porque mide menos de 2 cm
> **B)** Iniciar levotiroxina para frenar el crecimiento
> **C)** Cintigrafía tiroidea
> **D)** Tiroidectomía total sin estudio citológico
> **E)** Punción aspirativa con aguja fina guiada por ecografía
> Respuesta E. La ecografía es el examen que estratifica el riesgo del nódulo. Hipoecogenicidad marcada, forma más alta que ancha, bordes irregulares y microcalcificaciones son signos de sospecha alta (TI-RADS 5): se indica PAAF desde 1 cm. La cintigrafía solo se pide con TSH baja, y no se opera sin citología.

1.03.4.002 Densitometría ósea

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 7.18 Osteoporosis: Densitometría Ósea (DEXA), Criterios FRAX y Tratamiento

QUÉ HAY QUE SABER

- DEXA axial (columna L1–L4 y cadera) es el estándar de oro para la densidad mineral ósea; se compara con el adulto joven (T-score) y con la misma edad (Z-score).

- T-score (posmenopáusicas y hombres ≥50 años): ≥ –1,0 normal; entre –1,0 y –2,5 osteopenia; ≤ –2,5 osteoporosis (basta un sitio); con fractura por fragilidad, osteoporosis severa.
- Z-score (premenopáusicas y hombres <50 años): ≤ –2,0 = densidad baja para la edad, obliga a buscar causa secundaria (corticoides, hipogonadismo, celiaquía, hiperparatiroidismo).
- Indicaciones: mujeres ≥65 años, posmenopáusicas o hombres mayores con factores de riesgo, corticoides crónicos, fractura por fragilidad y control del tratamiento cada 1–2 años.
- Osteopenia: calcular FRAX (tratar si ≥20 % fractura mayor o ≥3 % cadera). Una fractura por fragilidad se trata aunque la DEXA no llegue a –2,5.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 38 años, con menstruaciones regulares, en tratamiento con prednisona 10 mg/día hace 14 meses por lupus. Se solicita densitometría ósea (DEXA): columna lumbar T-score –2,7 y Z-score –2,4; cuello femoral T-score –2,1 y Z-score –2,0. No tiene fracturas. **¿Cuál es la interpretación correcta de la densitometría?**
> **A)** Osteoporosis, porque el T-score es menor de –2,5
> **B)** Osteopenia, porque el cuello femoral está sobre –2,5
> **C)** Densitometría normal
> **D)** Densidad mineral ósea baja para la edad, según el Z-score, que es el índice que se usa en mujeres premenopáusicas
> **E)** Osteoporosis severa
> Respuesta D. El T-score compara con el adulto joven y diagnostica osteoporosis (≤ –2,5) en posmenopáusicas y hombres de 50 años o más. En premenopáusicas y hombres menores de 50 se usa el Z-score, que compara con la misma edad: ≤ –2,0 es densidad baja para la edad y obliga a buscar una causa secundaria, aquí los corticoides.

1.03.4.003 TSH, T4, T3

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo · Tema 1.2 Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina · Tema 7.6 Enfermedad de Graves-Basedow y Síndromes Tirotóxicos

QUÉ HAY QUE SABER

- La TSH ultrasensible es el examen inicial de elección ante cualquier sospecha tiroidea (VN adulto 0,4–4,5 mUI/L); pequeños cambios de T4 libre producen grandes cambios de TSH. Siempre interpretar junto a la T4 libre.
- Patrones: TSH alta y T4L baja = hipotiroidismo primario; TSH alta y T4L normal = subclínico; TSH <0,1 y T4L o T3 alta = hipertiroidismo; T4L baja con TSH baja o normal = hipotiroidismo central (RM de hipófisis y descartar insuficiencia suprarrenal).
- TSH suprimida con T4L normal y clínica de tirotoxicosis: medir T3 (T3-toxicosis, típica del adenoma tóxico y del bocio multinodular); si también es normal, hipertiroidismo subclínico.
- La T4 total se eleva con estrógenos (anticonceptivos, embarazo) por aumento de la TBG sin cambiar la hormona libre; preferir T4 libre.
- Paciente crítico con T3 baja, T3 reversa alta y TSH y T4L normales o bajas: eutiroideo enfermo; no tratar con levotiroxina y repetir el perfil semanas después del alta. Embarazo: metas de TSH <2,5 en el 1.er trimestre y <3,0 después.

PREGUNTAS (3)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 66 años en UCI por shock séptico de foco pulmonar, intubado y con noradrenalina. Perfil tiroideo de ingreso: TSH 0,6 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 0,82 ng/dL (VN 0,8–1,8), T3 total 35 ng/dL (VN 80–200) y T3 reversa muy elevada. Sin antecedentes de patología tiroidea ni bocio. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto del eje tiroideo?**
> **A)** Iniciar levotiroxina endovenosa en dosis sustitutiva completa
> **B)** Iniciar T3 (liotironina) por sonda nasogástrica
> **C)** Observar el eje tiroideo, tratar la sepsis y repetir el perfil semanas después del alta
> **D)** Solicitar resonancia de hipófisis por hipotiroidismo central
> **E)** Iniciar hidrocortisona y luego levotiroxina
> Respuesta C. Paciente crítico con T3 muy baja, T3 reversa alta y TSH y T4 libre normales: síndrome del eutiroideo enfermo. Es una respuesta adaptativa; la levotiroxina y la T3 están contraindicadas. Se trata la sepsis y se reevalúa el perfil semanas después del alta.

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años operada hace 8 meses de un macroadenoma hipofisario no funcionante. Consulta por astenia, intolerancia al frío y constipación. FC 58 lpm, piel seca. Exámenes: TSH 0,9 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 0,45 ng/dL (VN 0,8–1,8). Cortisol plasmático matinal normal. **¿Cuál es la interpretación y conducta más adecuada?**

A) Hipotiroidismo central; iniciar levotiroxina y controlar con T4 libre
B) Hipotiroidismo primario; ajustar la levotiroxina según la TSH
C) Eje tiroideo normal, porque la TSH es normal
D) Síndrome del eutiroideo enfermo; repetir en 6 semanas
E) Hipertiroidismo subclínico; observar

Respuesta A. Una T4 libre baja con TSH normal o baja, no elevada, indica hipotiroidismo central, aquí por daño hipofisario. La TSH deja de servir para el control: la levotiroxina se ajusta con la T4 libre, buscando la mitad superior del rango normal. Antes de iniciarla debe descartarse insuficiencia suprarrenal, ya resuelto en este caso.

Pregunta de práctica

Hombre de 58 años con palpitaciones, temblor fino y baja de 5 kg en 2 meses. FC 112 lpm, nódulo tiroideo palpable de 3 cm en el lóbulo derecho. Exámenes: TSH 0,01 mUI/L (VN 0,4–4,0), T4 libre 1,6 ng/dL (VN 0,8–1,8). **¿Cuál es el examen más adecuado para completar la evaluación de la función tiroidea?**

A) Repetir la TSH en 6 semanas, ya que la T4 libre es normal
B) Solicitar anticuerpos antitiroperoxidasa
C) Solicitar T3 total o libre
D) Solicitar tiroglobulina
E) Solicitar T3 reversa

Respuesta C. TSH suprimida con T4 libre normal en un paciente con clínica de tirotoxicosis obliga a medir la T3: probable T3-toxicosis, frecuente en el adenoma tóxico y el bocio multinodular tóxico. Si la T3 también es normal, se trata de un hipertiroidismo subclínico. Luego la cintigrafía define la etiología.

1.03.4.004 T4 libre

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.1 Fisiología Tiroidea, Interpretación de TSH/T4L y Síndrome del Eutiroideo Enfermo

QUÉ HAY QUE SABER

- Mide la hormona libre activa, sin influencia de la TBG (estrógenos, embarazo); complementa a la TSH y define el tipo de falla.
- T4 libre baja con TSH alta: hipotiroidismo primario clínico; T4L normal con TSH alta: subclínico; T4L alta con TSH suprimida: hipertiroidismo clínico.
- T4 libre baja con TSH baja o inapropiadamente normal: hipotiroidismo central (adenoma hipofisario, Sheehan, cirugía o radioterapia); antes de dar levotiroxina descartar insuficiencia suprarrenal.
- En el hipotiroidismo central y tras tiamazol inicial el control se hace con T4 libre (meta: mitad superior del rango normal), no con TSH, que tarda en recuperarse.
- En el paciente crítico puede bajar sin enfermedad tiroidea (eutiroideo enfermo): no tratar y reevaluar tras la recuperación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 33

Una paciente de 25 años acude a chequeo médico. Como antecedente, usa suplementos de vitamina D y anticonceptivos orales. Los exámenes de laboratorio muestran T4 total de 16 ng/mL (valor normal 5 a 12) y TSH de 0,9 mU/L (valor normal 0,5 a 5). El examen físico es normal. **¿Qué examen es el más adecuado para proseguir el estudio?**

A) Anticuerpos anti-receptor de TSH
B) Cintigrafía tiroidea
C) Triyodotironina (T3)
D) T4 libre
E) Tiroglobulina

Respuesta D. Los estrógenos (anticonceptivos, embarazo) elevan la globulina fijadora de tiroxina (TBG), por lo que la T4 total sube sin que cambie la hormona activa. La TSH normal ya descarta hipertiroidismo; si se quiere completar, se mide la T4 libre, que no depende de la TBG.

1.03.4.005 Anticuerpos antitiroideos (antitiroglobulina y antiiroperoxidasa)

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 1.2 Hipotiroidismo Primario y Subclínico: Diagnóstico y Titulación de Levotiroxina

QUÉ HAY QUE SABER

- Anti-TPO (antiperoxidasa) y anti-Tg (antitiroglobulina) marcan autoinmunidad tiroidea: positivos en más del 90 % de los Hashimoto.
- En el hipotiroidismo subclínico, anti-TPO positivos duplican el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico (cerca de 4 % al año) y apoyan tratar con TSH 4,5–9,9, sobre todo en embarazo o deseo de embarazo.
- Tiroiditis posparto y silente: anti-TPO positivos en 50–70 %, con mayor riesgo de hipotiroidismo definitivo; la De Quervain no es autoinmune (VHS alta, anticuerpos negativos).
- Los anti-Tg se piden siempre junto con la tiroglobulina en el seguimiento del cáncer diferenciado, porque la falsean hacia abajo.
- No confundir con TRAb (anticuerpos contra el receptor de TSH), que son los que confirman Graves.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Una mujer de 32 años, asintomática, tiene TSH de 7,2 μUI/mL con T4 libre normal, confirmados en 2 mediciones. No está embarazada ni lo planifica. **¿Qué examen ayuda más a estimar el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico?**
>
> **A)** Anticuerpos antiperoxidasa tiroidea (anti-TPO)
> **B)** Tiroglobulina
> **C)** Cintigrama tiroideo
> **D)** T3 total
> **E)** Calcitonina
>
> Respuesta A. En el hipotiroidismo subclínico, los anticuerpos anti-TPO positivos indican tiroiditis de Hashimoto y aproximadamente duplican el riesgo de progresión a hipotiroidismo clínico (cerca de 4% al año). Ayudan a decidir tratamiento y frecuencia de controles. La tiroglobulina es marcador tumoral del cáncer diferenciado tratado, y la calcitonina del carcinoma medular.

1.03.4.006 Cortisol plasmático

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 7.11 Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico · Tema 7.12 Insuficiencia Suprarrenal Crónica: Primaria (Addison) versus Secundaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Insuficiencia suprarrenal: cortisol plasmático a las 8 h <3 mcg/dL confirma, >15–18 la descarta; entre 3 y 15 es indeterminado y requiere test de Synacthen 250 mcg (pico <18 confirma).
- En la crisis suprarrenal se toma la muestra pero no se espera el resultado para dar hidrocortisona.
- Cushing: un cortisol matinal aislado no diagnostica ni descarta (está en su peak fisiológico); se usa en el test de Nugent (cortisol 8 h tras 1 mg de dexametasona, normal <1,8 mcg/dL).
- Los estrógenos (anticonceptivos, embarazo) elevan la CBG y el cortisol total, dando falsos positivos en el Nugent; en ese caso usar cortisol libre urinario.
- No sirve para ajustar la dosis de hidrocortisona en el paciente con reemplazo; tras confirmar alteración, la ACTH define el origen.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Hombre de 46 años con obesidad, hipertensión y DM2 de difícil control. Su médico sospecha síndrome de Cushing y solicita un cortisol plasmático a las 8 h, que resulta 21 mcg/dL (VN 5–25). Al examen no tiene estrías violáceas, miopatía proximal ni equimosis. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de este resultado?**

A) Descarta el síndrome de Cushing
B) No sirve para el tamizaje; se debe solicitar test de Nugent, cortisol libre urinario de 24 horas o cortisol salival nocturno
C) Confirma el síndrome de Cushing
D) Indica insuficiencia suprarrenal relativa
E) Obliga a solicitar TC de suprarrenales

Respuesta B. Un cortisol plasmático matinal aislado no diagnostica ni descarta Cushing: en la mañana el cortisol normal está en su peak y se superpone con el hipercortisolismo. El Cushing pierde la supresión y el ritmo circadiano, por eso se tamiza con Nugent, cortisol libre urinario o cortisol salival nocturno. El cortisol matinal sirve en la insuficiencia suprarrenal.

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años con astenia de 4 meses, baja de 5 kg y mareo al ponerse de pie. PA 100/65 mmHg. Sin hiperpigmentación. Na 134 mEq/L, K 4,4 mEq/L. Cortisol plasmático a las 8 h: 9 mcg/dL. **¿Cuál es el paso siguiente más adecuado?**

A) Descartar insuficiencia suprarrenal por cortisol normal
B) Test de estimulación con ACTH sintética (Synacthen 250 mcg)
C) Iniciar hidrocortisona y fludrocortisona
D) Test de supresión con dexametasona 1 mg
E) Tomografía computarizada de suprarrenales

Respuesta B. Un cortisol matinal entre 3 y 15 mcg/dL es indeterminado: no confirma ni descarta. Corresponde una prueba de estimulación con Synacthen 250 mcg; un pico menor de 18 mcg/dL confirma la insuficiencia. Luego la ACTH define si es primaria o secundaria.

1.03.4.007 Cortisol libre 24 horas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 7.11 Síndrome de Cushing: Algoritmo Diagnóstico y Diagnóstico Etiológico

QUÉ HAY QUE SABER

- Prueba de tamizaje de primera línea para síndrome de Cushing: mide la fracción libre de cortisol filtrada en 24 h.
- Se recomiendan 2 recolecciones con creatininuria para asegurar orina completa; un valor >3 veces el límite superior es muy sugerente.
- No se afecta por los estrógenos (anticonceptivos, embarazo), por lo que se prefiere cuando el test de Nugent puede dar falsos positivos.
- Falsos positivos: pseudo-Cushing (depresión, alcoholismo, obesidad mórbida), alta ingesta de líquidos; falsos negativos con insuficiencia renal o recolección incompleta.
- Se confirma hipercortisolismo con 2 pruebas alteradas (CLU, Nugent o cortisol salival nocturno); recién entonces se mide ACTH y se pide imagen.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 28 años, usuaria de anticonceptivos orales combinados hace 3 años, consulta por aumento de peso, acné e hipertensión reciente. Se sospecha síndrome de Cushing. Test de Nugent (1 mg de dexametasona a las 23 h): cortisol a las 8 h de 3,4 mcg/dL. No es posible suspender los anticonceptivos por 6 semanas. **¿Cuál es el examen más adecuado para continuar el tamizaje?**

A) Cortisol libre urinario de 24 horas
B) Cortisol plasmático a las 8 horas
C) Repetir el test de Nugent con 2 mg de dexametasona
D) ACTH plasmática
E) Resonancia magnética de silla turca

Respuesta A. Los estrógenos elevan la globulina transportadora de cortisol (CBG) y el cortisol plasmático total, dando falsos positivos en el test de Nugent. El cortisol libre urinario de 24 horas mide la fracción libre y no se afecta; se piden 2 muestras con creatininuria. La ACTH y la imagen van después de confirmar el hipercortisolismo.

1.03.4.008 FSH, estradiol y prolactina

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 7.21 Hiperprolactinemia y Prolactinomas: Diagnóstico y Terapia Médica · Tema 20.1 Fisiología del Ciclo Menstrual, Eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario y Estudio de la Amenorrea

QUÉ HAY QUE SABER

- En amenorrea, tras descartar embarazo con beta-hCG, se piden TSH, prolactina y FSH con estradiol.
- FSH elevada (>25–40 mUI/mL en 2 muestras separadas por 4 semanas) con estradiol bajo en menor de 40 años: insuficiencia ovárica prematura (hipogonadismo hipergonadotropo); en mujer >45 años con amenorrea confirma la menopausia, aunque no se pide de rutina.
- FSH y LH bajas o normales bajas con estradiol bajo: hipogonadismo hipogonadotropo (amenorrea hipotalámica funcional en deportistas o bajo peso, Sheehan, tumor hipofisario, Kallmann).
- Prolactina >25 ng/mL (en ayunas y reposo): descartar fármacos, hipotiroidismo y embarazo; >200 sugiere macroprolactinoma.
- En el SOP el estradiol es normal (test de progesterona positivo) y la relación LH/FSH puede estar aumentada; tomar FSH y estradiol en fase folicular precoz (días 2–5) si hay ciclos.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 34 años con amenorrea secundaria de 7 meses, bochornos, sudoración nocturna y sequedad vaginal. No usa fármacos ni anticonceptivos. Beta-hCG negativa, TSH 2,1 mUI/L, prolactina 14 ng/mL (VN menor de 25). FSH 68 mUI/mL, estradiol 12 pg/mL. Se repite la FSH a las 4 semanas: 72 mUI/mL. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Amenorrea hipotalámica funcional
B) Prolactinoma
C) Síndrome de Sheehan
D) Síndrome de ovario poliquístico
E) Insuficiencia ovárica prematura

Respuesta E. En la amenorrea, tras descartar embarazo, se piden TSH, prolactina y FSH con estradiol. FSH elevada (sobre 25–40 mUI/mL en 2 muestras separadas por 4 semanas) con estradiol bajo en una mujer menor de 40 años indica insuficiencia ovárica prematura: hipogonadismo hipergonadotropo. La amenorrea hipotalámica y el Sheehan tienen FSH baja o normal.

Pregunta de práctica

Mujer de 20 años, corredora de fondo, con amenorrea secundaria de 6 meses. Entrena 70 km por semana y bajó 7 kg en el último año; IMC 17,5. Beta-hCG negativa, TSH 1,9 mUI/L, prolactina 11 ng/mL. FSH 2,1 mUI/mL, LH 0,9 mUI/mL, estradiol 14 pg/mL. Prueba de progesterona negativa. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Amenorrea hipotalámica funcional
B) Síndrome de ovario poliquístico
C) Insuficiencia ovárica prematura
D) Síndrome de Asherman
E) Hiperprolactinemia

Respuesta A. FSH y LH bajas o normales bajas con estradiol bajo: hipogonadismo hipogonadotropo. En una deportista con bajo peso y déficit energético, la causa es la amenorrea hipotalámica funcional, con riesgo de pérdida de masa ósea. La insuficiencia ovárica tiene FSH alta; el SOP tiene estrógenos normales y prueba de progesterona positiva.

1.03.4.009 LH, testosterona

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 20.7 Infertilidad Conyugal: Estudio Básico Inicial en Cuatro Pilares y Técnicas de Reproducción Asistida

QUÉ HAY QUE SABER

- En el hombre con sospecha de hipogonadismo, la testosterona total matinal confirma y la LH clasifica: LH y FSH altas = hipogonadismo primario (Klinefelter, orquitis, quimioterapia); bajas o inapropiadamente normales = central (prolactinoma, tumor hipofisario, Kallmann).
- Klinefelter (47,XXY): testículos pequeños y firmes, azoospermia, ginecomastia y hábito eunucoide; se confirma con cariograma. Kallmann: gonadotropinas bajas y anosmia.
- Los esteroides anabólicos suprimen LH y FSH y atrofian los testículos.

- En la mujer: testosterona total o libre elevada apoya hiperandrogenismo (SOP); valores muy altos o virilización sugieren tumor ovárico o suprarrenal. La relación LH/FSH puede estar aumentada en el SOP, pero no es criterio diagnóstico.
- Con testosterona baja y LH no elevada en el hombre, pedir prolactina y RM de silla turca.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Un hombre de 28 años consulta por infertilidad conyugal de 2 años. Es alto, con escaso vello corporal, ginecomastia leve y testículos pequeños y firmes (3 mL). El espermiograma muestra azoospermia y la testosterona total es baja (180 ng/dL). **¿Qué resultado de LH y FSH es esperable y cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** LH y FSH bajas: hipogonadismo hipogonadotrópico (Kallmann)
> **B)** LH y FSH normales: obstrucción de conductos deferentes
> **C)** LH y FSH elevadas: hipogonadismo primario, probable síndrome de Klinefelter
> **D)** LH baja y FSH alta: prolactinoma
> **E)** LH alta y FSH baja: uso de esteroides anabólicos
>
> Respuesta C. Testículos pequeños y firmes, azoospermia, ginecomastia y hábito eunucoide con testosterona baja y gonadotropinas elevadas (hipogonadismo hipergonadotrópico) sugieren síndrome de Klinefelter (47,XXY), que se confirma con cariograma. En el hipogonadismo central (Kallmann, tumor hipofisario) LH y FSH están bajas o inapropiadamente normales; los anabólicos las suprimen.

1.03.4.010 PTH, calcemia

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 7.16 Hipercalcemia e Hiperparatiroidismo Primario versus Neoplásico

QUÉ HAY QUE SABER

- Interpretar el calcio corregido por albúmina: calcio + 0,8 × (4 – albúmina); en hipoalbuminemia la calcemia total baja puede ser normal (seudohipocalcemia).
- Hipercalcemia con PTH alta o inapropiadamente normal y fósforo bajo: hiperparatiroidismo primario. Con PTH suprimida: causa no paratiroidea (PTHrP del carcinoma escamoso, metástasis osteolíticas, mieloma, exceso de vitamina D o granulomas).
- PTH normal o algo alta con calciuria muy baja (FE Ca <1 %): hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que no se opera.
- PTH alta con calcio normal o bajo: hiperparatiroidismo secundario (déficit de vitamina D, enfermedad renal crónica); pedir 25(OH)D.
- Hipocalcemia con PTH baja: hipoparatiroidismo (posquirúrgico) o hipomagnesemia; con PTH alta: déficit de vitamina D o insuficiencia renal.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 79 años, hospitalizada por desnutrición y una neumonía, sin síntomas neuromusculares. Signos de Chvostek y Trousseau negativos. Exámenes: calcio plasmático total 7,8 mg/dL (VN 8,5–10,5), albúmina 2,0 g/dL, fósforo 3,5 mg/dL, magnesio 2,0 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. **¿Cuál es la interpretación más adecuada de la calcemia?**
>
> **A)** Hipocalcemia verdadera; iniciar gluconato de calcio endovenoso
> **B)** Déficit de vitamina D; iniciar colecalciferol en dosis altas
> **C)** Hipoparatiroidismo; solicitar PTH e iniciar calcitriol
> **D)** Calcemia corregida normal (cerca de 9,4 mg/dL), por hipoalbuminemia; no requiere tratamiento de calcio
> **E)** Hipocalcemia por hipomagnesemia
>
> Respuesta D. El calcio total se une en un 40 % a la albúmina. Calcio corregido = calcio medido + 0,8 × (4 – albúmina) = 7,8 + 1,6 = 9,4 mg/dL: normal. Es una pseudohipocalcemia por hipoalbuminemia, asintomática; si hay duda, se mide el calcio iónico. La PTH solo se estudia ante una hipocalcemia verdadera.

Pregunta de práctica

Hombre de 66 años, fumador de 45 paquetes-año, con 3 semanas de constipación, poliuria, baja de peso y somnolencia. Calcio total 13,2 mg/dL con albúmina 4,0 g/dL, fósforo 2,4 mg/dL, creatinina 1,3 mg/dL. PTH intacta 6 pg/mL (VN 15–65). La radiografía de tórax muestra una masa hiliar derecha. **¿Cuál es el mecanismo más probable de la hipercalcemia?**

A) Hiperparatiroidismo primario por adenoma paratiroideo
B) Intoxicación por vitamina D
C) Secreción de péptido relacionado con la PTH (PTHrP) por un carcinoma escamoso pulmonar
D) Hiperparatiroidismo terciario
E) Hipercalcemia hipocalciúrica familiar

Respuesta C. El primer paso ante una hipercalcemia es medir la PTH. PTH elevada o inapropiadamente normal indica hiperparatiroidismo primario; PTH suprimida indica una causa no paratiroidea, y en un fumador con masa pulmonar lo más probable es la hipercalcemia humoral maligna por PTHrP, típica del carcinoma escamoso. El PTHrP no se detecta en el ensayo de PTH intacta.

1.03.4.011 Calciuria

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 13.1 Cólico Renal y Litiasis Urinaria: TAC sin Contraste, Manejo del Dolor & Expulsión Espontánea

QUÉ HAY QUE SABER

- Calciuria de 24 h: parte del estudio metabólico de la litiasis recurrente (junto a oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, creatinina y volumen urinario).
- Hipercalciuria: >300 mg/día en hombres, >250 mg/día en mujeres o >4 mg/kg/día; la causa más frecuente en litiasis cálcica es la hipercalciuria idiopática, con calcemia y PTH normales.
- Con hipercalcemia y PTH alta orienta a hiperparatiroidismo primario (calciuria >400 mg/día es criterio de paratiroidectomía); una calciuria muy baja (FE Ca <1 %) con hipercalcemia sugiere hipercalcemia hipocalciúrica familiar, que no se opera.
- También aumenta en exceso de vitamina D, sarcoidosis, acidosis tubular renal distal y dieta alta en sodio o proteínas.
- Manejo de la hipercalciuria: abundante agua, dieta baja en sodio con calcio normal (no restringir lácteos) y, si persiste, hidroclorotiazida; citrato de potasio si hay hipocitraturia.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un hombre de 38 años ha tenido 3 episodios de cólico renal en 2 años por cálculos de oxalato de calcio. Su calcemia, PTH y función renal son normales. **¿Qué examen es el más importante para orientar la prevención de nuevos cálculos y cuál es el hallazgo más frecuente?**

A) Uricemia: hiperuricemia
B) Calciuria de 24 horas: hipercalciuria idiopática
C) Cistinuria: cistinuria
D) Urocultivo: infección por Proteus
E) Cintigrama renal: hidronefrosis

Respuesta B. La litiasis recurrente amerita estudio metabólico en orina de 24 horas (calcio, oxalato, citrato, ácido úrico, sodio, volumen). La alteración más frecuente en la litiasis cálcica es la hipercalciuria idiopática, con calcemia y PTH normales. Se maneja con abundante agua, dieta baja en sodio con calcio normal y, si persiste, tiazidas.